



Université
d'Abomey-Calavi

République du Bénin
Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique

Université d'Abomey - Calavi
Institut régional de santé publique Comlan
Alfred Quenum



Institut Régional de Santé
Publique Comlan Alfred

MASTER EN SANTE PUBLIQUE

SPECIALITE : POLYVALENTE

Mémoire N° 135-POLY/IRSP/2025

Evaluation de la performance des centres nutritionnels
ambulatoires et thérapeutiques dans la prise en charge de la
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans la zone
sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2025 au Bénin

Présenté par :

HALOGLA Bakpabawoui Joseph
Infirmier Diplômé d'Etat

Directeur de Mémoire

Dr AZANDJEME Colette
Maître de Conférences agrégé
IRSP-CAQ/UAC

Co-Directeur de Mémoire

Dr METONNOU Clémence
Assistante en Nutrition
IRSP-CAQ/UAC

Jury

Président

Dr KPATCHAVI Adolphe
Professeur Titulaire, Enseignant chercheur en
Sociologie et Anthropologie

Membres

Dr DJIDONOU Amselme
Professeur Titulaire en psychiatrie
Dr PADONOU Gérard
Maître de Conférences en Santé Publique,
Epidémiologie
Dr AZANDJEME Colette
Maître de Conférences agrégé, Nutrition

Année académique : 2024 - 2025

ACTION DE GRACE

Ô Miséricordieux, sans ta miséricorde, qui serais-je en jour ! Tes œuvres sont louables, admirables et tes desseins toujours réalisables. Raisons pour lesquelles ta grandeur est inestimable d'éternité en éternité et de génération en génération. Tu m'as choisi et j'ai répondu me voici, j'ai accompli la mission avec fierté dans la douleur grâce à ton accompagnement infailible. Soit glorifier à jamais.

C'est avec émotion que je vous exprime oh éternel, ma gratitude en m'inclinant devant ta face en ce jour solennel des rares jours de mon pèlerinage sur terre. Seule ta grâce infinie m'a permis de surmonter les obstacles et d'atteindre ce jalon important.

Que la gloire te soit rendue d'éternité en éternité, de génération en génération et à jamais !

Amen !!!

DEDICACE

Je dédie ce travail,

➤ **À ma chère épouse, DJANTA Malipata Sophie**

Je te transmets ce message avec un cœur rempli d'émotion et de reconnaissance. Je suis très marqué du courage et de l'abnégation dont tu as fait preuve en jouant à la fois le rôle de père et de mère au côté de notre progéniture durant mon absence. Femme battante, oh femme de courage, femme d'endurance, partage la grande joie qui m'anime en jour comme les grands jours de souffrance que nous avons partagé durant ces deux ans écoulés. Grâce à toi, j'ai réalisé un rêve qui me tenait à tout prix le cœur. Tu m'as toujours accompagné avec vive encouragement. Ce diplôme de Master est le fruit de notre collaboration sincère et franche, le produit d'une équipe. Je m'engage à utiliser les connaissances et les compétences acquises pour rendre la vie de nos communautés meilleures et te rendre fier de moi.

Je t'aime fort, ma fleur unique.

➤ **À vous, mes chers enfants, Carmel, Romaine, Siméon et Fridolin**

A chaque départ pour le Bénin, loin de verser les larmes, vous m'avez toujours souhaité un bon voyage. Je pourrais vous rappeler une de vos phrases « Papa, il faut bien apprendre ». Oui j'ai bien appris et voici mon diplôme que je vous dédie. Merci d'avoir accepté votre mère de jouer le rôle de guide à la fois père et mère durant mon absence.

➤ **À mes chers frères et sœurs Komi, Essowèréou, Essohana, Kpatcha, Naka et Bertille**

Merci pour votre soutien sous ses différentes formes. Vos prières ont été une arme redoutable pour mon combat. Soyez rassurer que je ferais l'honneur de notre famille à travers les services que je rendrai à la nos communautés.

➤ **A vous grand frère, ABALLE Akéi**

Votre soutien indéfectible et votre amour inconditionnel ont été mes plus grandes forces tout au long de ces deux ans d'endurance. Soyez-en fier de moi. Merci d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir encouragé à donner le meilleur de moi-même.

➤ **A vous grand frère, NABEDE Komla,**

Plus qu'un frère, vous êtes l'incarnation d'un de mes parents ou ancêtres. Je veux bien vous dire merci, mais je suis insignifiant pour le dire. Seul le Tout-Puissant Miséricordieux vous comblera de grâces pour tout votre impact dans ma vie.

IN MEMORY

➤ **A ma défunte maman, ATCHOLE Sika**

A peine quelques années de vie d'ensemble, tu nous fis arrachée comme un tonnerre dans un ciel serein. Chère maman, tu as été pour moi un modèle de force, de courage et de détermination dans ton silence. Ce travail est le fruit de tes orientations mystérieuses. Paix à ton âme.

➤ **A mon feu Père, HALOGLA Ténou**

Cher papa alors que maman t'abandonnait toute la famille, toi aussi, tu n'as pas résisté à la tempête, nous laissant orphelins de tout bord. Père, retrouve ton image dans ma personne. Que la terre te soit légère.

Malgré tout, vous êtes restés une couverture cachée pour moi et je ne manque pas de vos prières. Votre présence m'envahit chaque jour de ma vie.

A mon père adoptif, HALOGLA Dadja Sonzo

Depuis l'adolescence, tu as accepté bon gré, mal gré de jouer le rôle de nos deux parents disparus. J'ai tout appris avec toi. Même si je peux tout perdre, j'en garderais « l'humilité, le courage et la détermination ». Je me battais corps et âme pour qu'un jour tu aies le sourire toi aussi. Malheureusement mon espoir s'est transformé en larmes en pleine formation de ce master. Irrésistiblement, celui que je considérais comme père et mère s'en est allé aussi à jamais. Tu m'as construit plus qu'une fondation en béton, je défendrai ton nom. Je me prosternerai toujours devant ta tombe. Repose-toi en paix.

REMERCIEMENTS

Du fond du cœur, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce mémoire. En particulier, mes remerciements vont :

- **Au professeur DJOGBENOU S. Luc, Directeur de l'IRSP**, pour la rigueur mise en œuvre dans notre encadrement. Vos précieux conseils et votre soutien tout au long de notre formation est une preuve d'un bon gestionnaire ;
- **Au professeur SOSSA JEROME Charles, Directeur Adjoint chargé des études à l'IRSP**, pour vos efforts inestimables pour faire de nous des apprenants complets à répondre au nouveau marché de travail ;
- **Au Maître de Conférence MAKOUTODE Patrick Charles, notre chef département et chef filiaire**, nous sommes reconnaissants à votre égard pour tout votre accompagnement indéfectible, trouvez ici l'expression de notre profond respect ;
- **A tout le corps enseignant de l'IRSP** pour tous les efforts déployés afin de nous dispenser un enseignement de qualité qui répond aux exigences du marché actuel ; trouvez ici l'expression de notre profonde reconnaissance ;
- **A tout le personnel de l'IRSP** pour l'accueil et pour les services que vous nous avez rendus au cours de ces deux années de formation au sein de l'institut ;
- **A la Coordinatrice de Zone Sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké, Dr Honorine Affi ATCHI** pour votre soutien sans faille durant notre séjour de stage dans votre zone sanitaire. Vos encouragements constants et votre coordination ont été pour nous une source de motivation inestimable tout au long de ce séjour avec vous ;

➤ **Au médecin chef de l'Hôpital de Zone Ordre de Malte de Djougou,
EGOUNLETY Hubert Charlemagne,**

Cher encadreur, trouver ici notre merci qui vient du fond du cœur pour votre encadrement stratégique qui nous a facilité la collecte de données. Soyez rassuré que nous vous resterons reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de grâce ;

➤ **A tout le personnel de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké,**

Vous étiez nombreux à nous accompagner en nous fournissant les données lors de ma collecte. Vous avez permis la réussite de notre travail. Trouvez ici nos mots francs de remerciement ;

➤ **A vous, cher maître GNAROU Takpaya,**

Vous m'avez accompagné durant les deux ans de dure labeur et vous avez été toujours présent à chaque fois que le besoin était là. Je suis très reconnaissant et vous resterai un maître pour nous ;

➤ **A mes cousins Paul, David, Bolom, Essotina, Essossolam**

Vous êtes une source de courage et d'inspiration pour nous. Vous avez toujours témoigné de la qualité de notre relation.

A vous M'PESSI Christian Aurel et KPONASSE Jean-Paul,

Vous avez agi dans l'ombre pour nous permettre de surmonter les difficultés qui nous faisaient face, j'en suis ému de votre parfait engagement et détermination bénévoles. Merci infiniment ;

➤ **A vous, chers camarades de promotion 2023-2025,**

Les mots me manquent pour témoigner de la franche collaboration durant notre séjour à Ouidah. Notre soutien mutuel et les bons moments passés ensemble sont une preuve. Puisse le Seigneur offrir à chacun de nous la place qu'il mérite.

HOMMAGES

- **Au Maître de Conférence Agrégé, AZANDJEME Colette, notre maître et Directrice de mémoire.**

Cher AZANDJEME Colette,

Je vous suis et resterai infiniment reconnaissant pour votre encadrement exceptionnel durant ce mémoire de Master en Santé Publique. Ce qui nous a permis d'améliorer significativement notre travail. Votre passion, votre expertise et votre engagement pour la Santé Publique nous inspire.

Je vous remercie sincèrement pour ce soutien indéniable. Ce mémoire vous est dédié en vue de vous exprimer notre profonde gratitude.

- **A l'Assistante METONNOU Clémence, notre Co-Directrice de mémoire,**

Je tiens une fois encore à vous dire un merci franc pour votre contribution remarquable à mon mémoire de Master. Votre encadrement nous a également permis de produire un travail de qualité.

LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES et SIGLES

ATPE	: Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi
CPC	: Control Promotion Croissance
CNA	: Centre Nutritionnel Ambulatoire
CNT	: Centre Nutritionnel Thérapeutique
CREN	: Centre de Récupération et d'Education Nutritionnelle
DCO	: Djougou-Copargo-Ouaké
EEZ	: Equipe d'Encadrement de Zone
FoSa	: Formation Sanitaire
HZOM	: Hôpital de Zone Ordre de Malte
MAG	: Malnutrition Aigüe Globale
MAS	: Malnutrition Aigüe Sévère
MUAC	: Mid-upper Arm Circumference
PB	: Périmètre Brachiale
PECMA	: Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë
RC	: Relai Communautaire
RCR	: Référence Contre Référence
VAD	: Visite à Domicile
ZS	: Zone Sanitaire

RESUME

Introduction : La malnutrition aiguë est un problème de santé publique qui affecte toutes les tranches d'âge, mais particulièrement les enfants de moins de cinq ans. Elle laisse d'énormes conséquences chez ces enfants tels que : les décès, les handicaps et les rend vulnérables. Cette étude avait pour objectif d'évaluer la performance des centres nutritionnels dans la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2025 au Bénin.

Méthodes : L'étude, transversale et évaluative a été menée de Janvier à juillet 2025. Un échantillon de 49 agents de santé, 43 relais communautaires, 235 malnutris ont été sélectionnés à l'aide d'un échantillonnage non probabiliste dans 45 centres de prise en charge. L'étude a évalué la performance des centres nutritionnels qui a été appréciée en utilisant l'échelle adaptée de Varkevisser.

Résultats : La performance des centres nutritionnels ambulatoires était globalement jugée moyenne avec un score de 1 425 (70,32%) sur 1 806 attendu. La composante « Structure » a été jugée moyenne avec une proportion de 70,32%, celles de « Processus » et « Résultats » ont été jugées bonnes avec respectivement 87,70% et 87,50%. La performance des centres nutritionnels thérapeutiques est globalement jugée bonne avec une proportion de 83,83%.

Conclusion : Le renforcement des compétences du personnel impliqué et la disponibilité des intrants permettront d'améliorer la prise en charge de la malnutrition.

Mots clés : Malnutrition aiguë, performance, évaluation.

ABSTRACT

Introduction: Acute malnutrition is a public health problem affecting all age groups, but particularly children under five. It has enormous consequences for children, including death, disability and vulnerability. The aim of this study was to assess the performance of nutrition centers in the management of acute malnutrition in children under five in the Djougou-Copargo-Ouaké health zone in 2025 in Benin.

Methods: The cross-sectional, evaluative study was conducted from January to July 2025. A sample of 49 health workers, 43 community relays and 235 malnourished people were selected using non-probability sampling in 45 care centers. The study assessed the performance of the nutrition centers using the adapted Varkevisser scale

Results: The performance of ambulatory nutrition centers was judged to be average overall, with a score of 1,425 (70.32%) out of 1,806 expected. The “Structure” component was judged average with a proportion of 70.32%, while the ‘Process’ and “Results” components were judged good with 87.70% and 87.50% respectively. Overall, the performance of the therapeutic nutrition centers was judged to be good, with a proportion of 83.83%.

Conclusion: Strengthening the skills of the staff involved, and ensuring the availability of inputs, will make it.

Key words: Acute malnutrition, performance, evaluation.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Indicateurs de performance des centres de prise charge de la malnutrition	19
Tableau II : Techniques d'échantillonnage	28
Tableau III : Nombre d'individus inclus dans l'étude de la performance des CNA et CNT	29
Tableau IV : Modalités et critères de cotation.....	30
Tableau V : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « structure de la prise en charges » dans les CNA de la ZS DCO en 2025	32
Tableau VI : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charges » dans les CNA la ZS DCO en 2025.....	36
Tableau VII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « résultats de la prise en charge » dans les CNA dans la ZS DCO en 2025	40
Tableau VIII : Synthèse des aspects opérationnels des composantes « structure », « processus » et « résultats » dans les CNA de la ZS DCO en 2025	42
Tableau IX : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « Structure de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025	44
Tableau X : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025	48
Tableau XI : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « résultats de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025	51
Tableau XII : Synthèse de l'appréciation des composantes « structure » et « processus » et « résultats » dans les centres nutritionnels thérapeutiques de la ZS DCO en 2025.....	52

Tableau XIII : Techniques et outils utilisés pour la collecte des données dans la ZSDCO en 2025	53
Tableau XIII : Présentation des résultats de la sous-composante « ressources humaines » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025 ...	58
Tableau XIV : Cibles d'étude associée à l'âge moyen, le sexe et le niveau d'étude.....	61
Tableau XV : Présentation des résultats de la sous-composante « ressources matérielles » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025	59
Tableau XVI : Présentation des résultats de la sous-composante « ressources informationnelles » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025	60
Tableau XVII : Présentation des résultats de la sous-composante « disponibilité des intrants » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025	61
Tableau XVIII : Synthèse des résultats de la composante « Structure » des CNA/CNT en 2025.....	62
Tableau XVIII : Présentation des résultats de la sous-composante « dépistage et prise en charge » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025	63
Tableau XIX : Présentation des résultats de la sous-composante « système de suivi des malnutris » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025	64
Tableau XX : Présentation des résultats de la sous-composante « Coordination » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025.....	65
Tableau XXI : Présentation des résultats de la sous-composante « sensibilisation » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025.....	66
Tableau XXII : Synthèse des résultats de la composante « Processus » des CNA/CNT en 2025.....	67

Tableau XXIII : Présentation des « résultats » de la prise en charge MAS par commune dans les CNA en 2025	68
Tableau XXIV : Présentation des « résultats » de la prise en charge MAS par commune des CNT en 2025	72
Tableau XXV: Présentation des résultats de la composante « résultats » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025.....	73
Tableau XXVII : Score obtenus de la sous-composante « résultats » en 2025	75

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Cadre conceptuel de l'évaluation de la performance des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques dans la prise en charge de la malnutrition adapté du modèle logique d'intervention de Donabedian.....	9
Figure 2 : Carte géographique de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké..	25
Figure 3 : Digramme d'Ishikawa des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNA de DCO.....	81
Figure 4 : Digramme d'Ishikawa des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNT de DCO.....	82
.....	
Figure 5 : Image de la séance du briefing des enquêteurs	II
.....	
Figure 6 : Matériel de jeux des malnutris (CNT Ordre de Malte)	III
Figure 7 : Image de la note d'autorisation de collecte des données.....	V

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
1- PROBLEMATIQUE	4
2-GENERALITES.....	14
3-METHODES D’ETUDE	23
4-RESULTATS	Erreur ! Signet non défini.
5-DISCUSSIONS	83
CONCLUSION	91
SUGGESTIONS & RECOMMANDATIONS	90
REFERENCES	104
ANNEXES	I
TABLE DES MATIERES	xxiv

INTRODUCTION

L'état nutritionnel des enfants influence directement leur état de santé général. Lorsque ces enfants bénéficient d'une alimentation équilibrée, ils sont rarement exposés à des maladies récurrentes. Ainsi, ils atteignent leur potentiel de croissance normal [1]. Mais une mauvaise alimentation peut conduire entre autres à la malnutrition qui se présente sous formes de carences, d'excès ou des déséquilibres dans l'apport énergétique et/ou nutritionnel d'une personne. Elle se traduit par la dénutrition, le retard de croissance, l'insuffisance pondérale ou le surpoids/obésité [2].

Sans exception, tous les continents sont touchés par ce phénomène. Cependant, les pays en voie de développement supportent le plus grand nombre de cas de malnutris chez les moins de 5 ans, en Afrique Sub-Saharienne en particulier. En 2022, on estimait à 149 millions environ, le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui présentaient un retard de croissance dans le monde [3].

Bénigne ou modérée, la malnutrition a des conséquences graves sur le développement des enfants. Les enfants qui survivent de cette tare ont une capacité d'apprentissage faible [4].

La lutte contre la malnutrition, constitue un objectif de développement majeur pour les structures sanitaires surtout ceux du premier contact. En effet depuis 2011, la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats appelait déjà à s'attaquer à ce mal qu'est la malnutrition [5].

Au Bénin, selon l'Enquête Démographique et de Santé EDS-MICS6-Bénin 2021-2022, la prévalence de la malnutrition était respectivement de 5,90% ; 36,60% et 2,40% pour l'insuffisance pondérale, retard de croissance et l'émaciation [6].

Les mesures sont prises au Benin pour lutter contre ce mal. Ainsi les formations sanitaires (FoSa) périphériques sont érigés en centres nutritionnels ambulatoires (CNA) et ceux hospitaliers en centre nutritionnels thérapeutiques (CNT) qui constituent des centres de référence des cas avec complications.

La zone sanitaire Djougou-Copargo- Ouaké n'échappe pas à ce phénomène. Mais force est de savoir qu'en 2024, certaines formations sanitaires ne faisaient pas la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS). Sur 51 centres publiques que compte la zone sanitaire, 11,76% n'en faisaient pas la prise en charge de la malnutrition. De plus, le taux de couverture de la cible MAS était très faible 46,80% (2443/5220).

C'est dans ce cadre que nous avons entrepris d'évaluer la performance desdits centres dans la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Le présent document s'est articulé autour des points suivants : introduction, problématique, revue de littérature, méthode d'étude, résultats et discussions, conclusion et suggestions et terminer par un plan tactique.

1. PROBLEMATIQUE

1.1 Enoncé du problème

Pendant les cinq années premières de vie, les enfants sont confrontés à de multiples pathologies, en particulier la malnutrition. Ces années constituent donc des moments délicats de leur vie qu'il faut prendre au sérieux [7].

Parmi ces enfants, ceux qui souffrent de l'émaciation ont une forte probabilité de mourir de maladies infantiles courantes. Les trois quarts d'entre eux qui meurent de causes liées à la malnutrition ne présentaient que des formes légères ou modérées de dénutrition, ce qui signifie qu'ils ne montraient que peu de signes extérieurs de leur vulnérabilité. Ainsi L'Objectif de Développement Durable 2 prévoit dans sa cible 2.2 de mettre fin à toutes les formes de la malnutrition d'ici 2030 en réalisant à tout niveau d'ici 2025, les objectifs arrêtés à l'échelle internationale relatifs aux retard de croissance et à l'émaciation parmi les enfants de moins de cinq ans [8].

Ce mal qu'est la malnutrition, résulte d'interactions entre plusieurs facteurs multiples et multisectoriels. Elle met particulièrement en jeu un ensemble de facteurs économiques, sociaux et culturels souvent liés à la pauvreté. Elle constitue donc un problème de santé publique [9].

En 2020, l'OMS estimait à près de 144 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance, 49,5 millions d'émaciation dont la moitié se trouvaient en Asie et en Afrique Subsaharienne [10].

Près de 90% des enfants malnutris aigus du monde vivent dans 36 pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud également. La malnutrition constitue une des principales causes de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans les pays en voie de développement. En effet, près d'un enfant de moins 5 ans sur trois était touché par au moins une forme de malnutrition. Ce qui représentait plus

de 200 millions d'enfants souffrant de dénutrition ou de surpoids à travers le monde [3].

Selon l'enquête nutritionnelle et de mortalité rétrospective de type SMART-2018, la malnutrition constituait une préoccupation sociale et sanitaire majeure. Les résultats d'une enquête au Mali étaient de : 10% pour la malnutrition aiguë, 24,10% pour malnutrition chronique et de 18,60% pour insuffisance pondérale. En 2020, l'Afrique représentait 40% de retard de croissance dans le monde chez les enfants de moins de 5 ans [11].

Les formes les plus sévères et les plus rencontrées dans la malnutrition étaient : le marasme et kwashiorkor en Afrique. Mais le "marasme" est le syndrome le plus fréquent de la malnutrition aiguë sévère [12].

Le rapport 2018 sur la nutrition mondiale indique que la sous-alimentation causait environ 45 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans, particulièrement dans les pays de faible revenu et intermédiaire. Cette affection est associée à environ près de la moitié des décès survenant chez ces enfants sur tous les continents [13].

Au Bénin, la malnutrition reste l'un des principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles. Les conséquences de la malnutrition sont indéniables sur la santé et le capital humain, et les répercussions sur le développement socio-économique du pays. Ainsi, les pertes du PIB attribuables à la malnutrition avait atteint 2 à 3% [14].

Selon les données de l'Enquête Démographique et de Santé EDS (MICS-Bénin), le retard de croissance était passé à 32% à 36,60% respectivement de la période 2017-2018 à la période 2021-2022 [15].

Les prévalences étaient très élevées dans le département de la Donga pour l'émaciation et l'obésité par rapport au niveau national. Elles étaient de 3,50% et 3,30% contre 2,4% et 1% respectivement pour ledit département et le niveau

national. Globalement les différentes prévalences étaient également plus élevées que celles des autres départements à l'exception de celui de Alibori selon le même rapport MISC6-Bénin 2021-2022 [15].

Sachant que la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké fait partie du département de la Donga, nous avons choisi de mener notre étude dans ladite zone pour mieux comprendre les raisons de ces prévalences élevées.

Face à ces différentes données, nous nous sommes posés ainsi des questions de savoir :

- ✍ Pourquoi les prévalences étaient-elles plus élevées dans ce département par rapport aux autres et au plan national ?
- ✍ Quelles étaient les performances des centres nutritionnels dans la prise en charge de la malnutrition dans cette zone ? Quelles étaient les faiblesses liées à une mauvaise performance ?

Une réponse à ces interrogations est primordiale pour aider les dirigeants de la zone sanitaire DCO en vue de mettre des plans efficaces pour une meilleure prise en charge de la malnutrition. C'est à cette fin que notre étude a été menée.

1.2 Cadre conceptuel

Afin de mieux aborder ce sujet portant sur l'« Evaluation de la performance des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques dans la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans », nous avons proposé le cadre conceptuel adapté du modèle logique d'intervention de Donabédian [16].

Le présent cadre conceptuel s'articule autour de deux grandes parties essentiellement :

- ✍ La composante principale qui est représentée par performance des CNA et CNT de la prise en charge de la malnutrition.

- ✍ Les composantes explicatives qui sont la structure, le processus, les résultats.

1.3 Schéma du cadre conceptuel

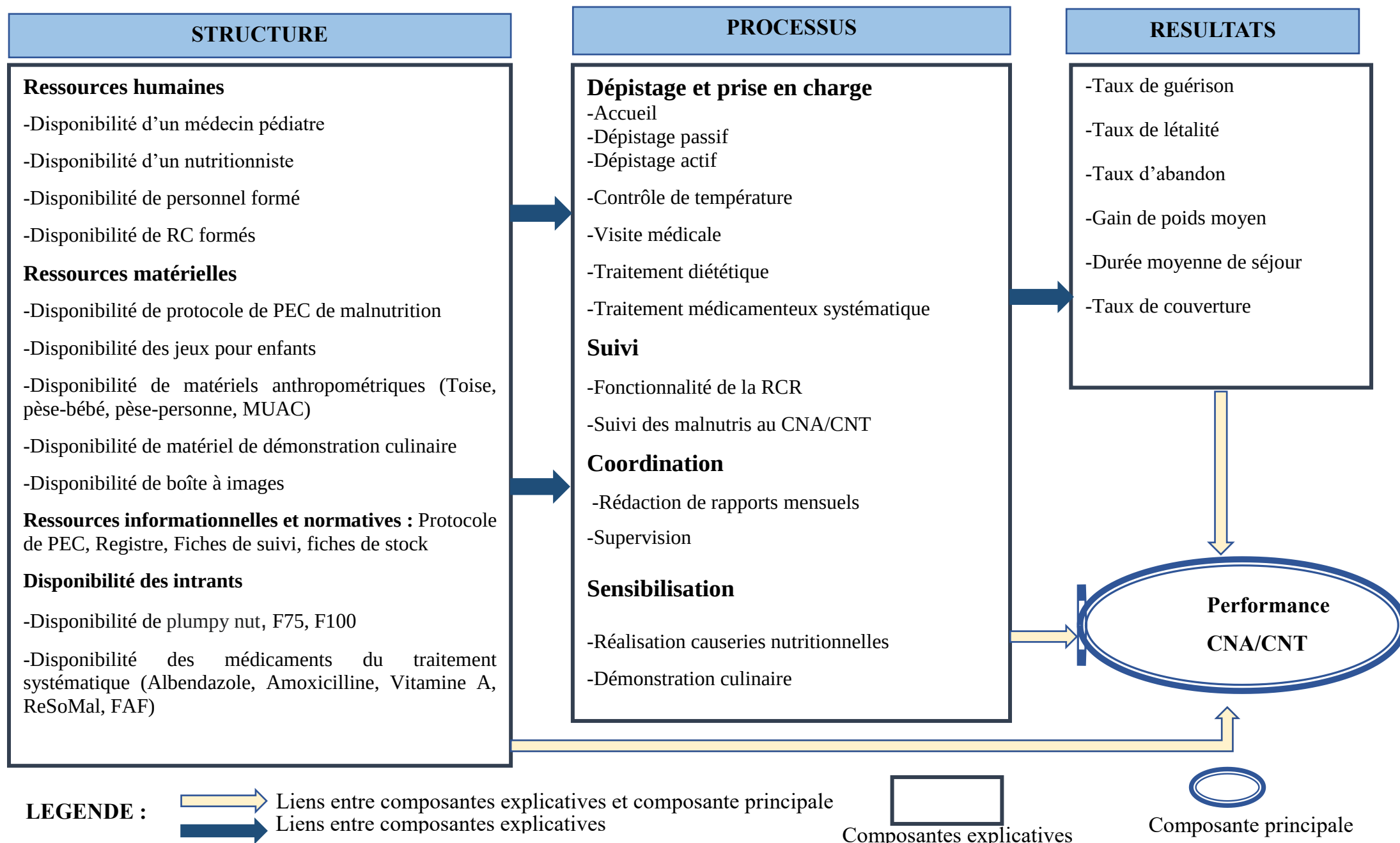


Figure 1: Cadre conceptuel de l'évaluation de la performance des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques dans la prise en charge

1.3.1 Explication du cadre conceptuel

Le cadre conceptuel de notre étude présente les rapports entre les différentes composantes explicatives (la structure, le processus et les résultats) et la composante principale représentée par la performance des CNA et CNT dans la prise en charge de la malnutrition.

1.3.1.1 Lien entre la composante « structure » et la performance des CNA et CNT à la zone sanitaire DCO

La performance de la prise en charge de la malnutrition est profondément influencée par la compétence du personnel impliqué. Ainsi les ressources humaines qualifiées et formées sont indispensables. Leur formation continue est une nécessité.

Par ailleurs, les ressources matérielles sont aussi importantes pour permettre au personnel d'exécuter leurs tâches avec aisance.

La disponibilité des intrants va permettre non seulement la satisfaction des clients mais accroît aussi le taux de guérison et augmente aussi la confiance des clients à l'établissement.

Quant aux ressources informationnelles et normatives, elles servent de base aux prestataires. Par exemple, le protocole de prise en charge, est une référence incontournable pour avoir toutes les indications de prise en charge.

Ainsi, l'interaction entre ces différentes sous-composantes ressources humaines, matérielles, informationnelles et normatives, la disponibilité des intrants est essentielle pour assurer une prise en charge efficace de la malnutrition.

1.3.1.2 Lien entre la composante « processus » et la performance des CNA et CNT à la zone sanitaire DCO

La prise en charge de la malnutrition repose sur un ensemble de processus clairement défini qui garantissent l'efficacité de cette dernière.

Cette prise en charge part du diagnostic réalisé lors des dépistages. Ainsi, ce dépistage doit être systématique pendant la consultation curative des enfants malades ou pendant la vaccination de routine (c'est le dépistage passif) ou faire des stratégies avancées dans la communauté (dépistage actif). Le respect de la prise des paramètres anthropométriques permet de mieux classer l'enfant selon son état nutritionnel et permet d'en faire des diagnostics exhaustifs.

Le respect du traitement est à prendre en compte pour faciliter une guérison rapide.

L'implication des relais Communautaires (RC), permet le dépistage d'un grand nombre d'enfants et permet également leur suivi. Ce suivi est bénéfique pour l'observance du traitement et permet d'apprécier l'évolution de chaque malnutri. Cette implication permet d'obtenir de bons résultats à travers le suivi des RC.

Des supervisions formatives sont capitales pour l'amélioration des compétences des prestataires impliqués.

Un système de référence contre référence dynamique permet un bon suivi des patients entre le niveau communautaire et les centres de prise en charge CNA/CNT et vice versa.

Le remplissage correct des supports et l'existence de rapports d'activités témoignent de la réalisation effective des activités par les agents. Mais aussi de la conscience professionnelle et de l'engagement de ces derniers dans leur tâche. Les sensibilisations et démonstrations culinaires donnent des compétences aux femmes pour adopter de bonnes pratiques alimentaires et l'hygiène de vie.

Ce processus bien respecté, permet d'obtenir une bonne performance de la prise en charge de la malnutrition et réduire le nombre de cas.

1.3.1.3 Lien entre la composante « résultats » et la performance des CNA et CNT à la zone sanitaire DCO

Le taux de guérison apprécie le nombre de malnutris guéris par rapport à ceux qui sont sortis.

Le taux de létalité indique une valeur issue du rapport entre les décès et les sorties.

Le taux d'abandon représente une valeur des abandons sur les sorties.

Le taux de couverture est la valeur issue du rapport entre la cible dépistée par rapport la cible attendue.

Le gain de poids est égal à la différence entre le poids de sortie (g) et poids minimum (g) le tout rapporté à la durée de séjour multiplier par le poids minimum (kg).

Ces différents indicateurs permettent d'apprécier la performance des structures de prise en charge de la malnutrition.

1.4 Hypothèse

Les centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques ne sont pas performants dans la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2024.

1.5 Objectifs

1.5.1 Objectif général

Etudier la performance des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques dans la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2025.

1.5.2 Objectifs spécifiques

1. Décrire les structures de prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans les centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2024 ;
2. Analyser les processus de prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans les centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2024 ;
3. Evaluer le niveau de performance de la prise charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans les centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2024 ;
4. Identifier les facteurs associés à la faible performance des centres nutritionnels.

2. GENERALITE

2.1 Définition opératoire des concepts et termes essentiels

La performance

C'est la capacité du système logique à rendre accessible les intrants de prise en charge de la malnutrition de bonne qualité et à satisfaire les clients [17].

Evaluation

C'est apprécier et comparer les caractéristiques observables de la mise en œuvre d'un processus à des politiques, normes établies afin de détecter, quantifier les écarts pour des prises de décisions permettant de fournir des mesures correctrices pour l'amélioration du processus vers l'atteinte des objectifs fixés [18].

Dans notre cas c'est le résultat de l'exécution d'une tâche conformément aux normes et critères définis afin d'atteindre pleinement les objectifs fixés dans la prise en charge de la malnutrition.

Centres nutritionnels ambulatoires (CNA)

Formations sanitaires qui font la prise en charge des cas de malnutrition sans complications médicales. Le traitement se fait avec à l'ATPE et le traitement médicamenteux systématiques sans hospitalisation. A chaque semaine, l'enfant est ramené pour le suivi ou les paramètres anthropométriques sont évalués de nouveau. L'âge des enfants étant compris entre 6 à 59 mois.

Centres nutritionnels thérapeutiques (CNT)

Formations sanitaires qui font la prise en charge des cas de malnutrition avec complications médicales. L'hospitalisation est systématique et obligatoire. La prise en charge est médicale et nutritionnelle (à base de F75, F100, bouillie améliorée). Les enfants sont suivis deux fois par jour. Ils sont compris entre la tranche 0 à 59 mois.

Protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë du Bénin

Document de référence qui sert de guide aux agents de santé et relais communautaires qui interviennent dans la prise en charge de la malnutrition au Bénin.

La compétence technique

La compétence peut être définie comme un savoir agir en situation professionnelle. La compétence technique se réfère aux connaissances, aptitudes et habiletés d'un agent de santé formé à exécuter correctement les tâches dont il a la charge [18].

Dans notre cas, il s'agit : des connaissances des directives de la PECMA par l'agent de santé

Les aptitudes de l'agent à prendre les mesures anthropométriques, à identifier les critères d'admission et à procéder à un bon traitement des cas, à identifier les cas graves et à référer à temps.

Dépistage actif

Stratégie qui consiste à aller dans les communautés pour prendre les paramètres anthropométriques chez les enfants, les classés selon leur état nutritionnel et prodiguer les conseils aux mères.

Dépistage passif

C'est une stratégie qui consiste à prendre les mesures anthropométriques chez les enfants que les parents amènent en consultation curative ou en contrôle de promotion de la croissance (CPC) et les classés selon leur état nutritionnel.

Relai Communautaire

Personne volontaire recrutée et formée faisant partie de la base du système sanitaire qui a pour rôle d'assurer des activités de santé et de nutrition dans sa communauté par les visites à domiciles et les sensibilisations.

Malnutrition

Par « malnutrition », nous entendons les carences, les excès ou déséquilibres dans l'apport énergétique et/ou nutritionnel d'une personne [2].

Prise en charge de la malnutrition aiguë

Intervention nutritionnelle qui consiste à faire le dépistage des cas de malnutrition et à assurer un traitement en médicamenteux et diététique.

Marasme

Le marasme nutritionnel est une forme de malnutrition grave du fait d'une insuffisance énergétique globale, accompagnée de carence en protéine. Il entraîne une importante perte de poids et un retard de croissance [19].

Kwashiorkor

C'est un syndrome de malnutrition par carence en protéines. Il se caractérise par la fonte musculaire, des œdèmes des membres inférieurs, une ascite, une hépatomégalie [20].

Aliments Thérapeutiques Prêts à Emploi (ATPE)

Aliments en pâte dans les sachets ou en poudre très riches en vitamines et en teneur énergétique et prêts à être consommés. Ils sont utilisés pour le traitement en CNA/CNT [21].

Taux de guérison

Rapport du nombre d'enfants guéris dans le service sur le nombre de sorties dans une période donnée (guéris + abandon+ décès) [22].

Taux de létalité

Rapport du nombre de décès liés à la malnutrition dans le service sur le nombre de sorties dans une période donnée (Registre de prise en charge Malnutrition Aigüe Sévère) [22].

Taux d'abandon

Rapport entre le nombre d'abandons et le nombre de sorties dans une période donnée (Registre de prise en charge Malnutrition Aigüe Sévère) [22].

Durée moyenne de séjour

Rapport de la somme des jours des guéris de l'admission à la guérison par le nombre de patients guéris [22].

Gain de poids moyen

Rapport de la somme des gains de poids des guéris sur le nombre total de guéris [22].

2.2 Quelques informations sur la malnutrition

2.2.1 Historique de la prise en charge de la malnutrition aiguë

Les efforts de lutter contre la malnutrition ne date pas de ce jour. En effet le combat contre cette affection a vu le jour depuis 1950. Les résultats de cette lutte étant très décevant, une nouvelle politique de lutte est née. Il s'agit de l'approche communautaire mise en place dans la plupart des pays qui a permis d'améliorer la prise en charge de plus de 85% des malnutris en ambulatoire. Cette prise en charge à base d'aliments thérapeutiques prêt à l'emploi (ATPE) et le traitement systématique avec certains médicaments, a permis aussi de réduire la mortalité et

certaines conséquences néfastes sur l'enfant à cause du dépistage précoce. Pour les cas MAS avec complications médicales, la prise en charge se fait dans les centres hospitaliers accrédités à cet effet [23].

Au Bénin, la Prise en Charge communautaire de la Malnutrition Aiguë (PECMA) a été marquée par un certain nombre d'évènements saillants. Il s'est agi de la formation des formateurs s'est tenue à N'Djamena au Tchad en avril 2007, avec l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). En juillet 2007, un atelier des formateurs a défini et mis en œuvre les étapes de la prise en charge au niveau départemental. Après tout ce processus, les zones sanitaires de Kandi-Gogounou-Segbana et de Banikoara ont servi leur cadre pour la mise en place du programme de PECMA [23].

2.2.2 Informations sur le fonctionnement des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques

L'approche PECMA comprend plusieurs composantes. Cependant, nous avons développé ceux qui ont un lien avec notre étude. Il s'agit de :

- ✍ « Réseau de relais communautaires (RC) pour la mobilisation et le dépistage actif communautaire » : il donne les compétences et l'attribution aux relais communautaires à faire des sensibilisations sur l'hygiène alimentaire, le dépistage actif des cas à travers les visites à domicile, les référence des cas vers les centres nutritionnels, le suivi des malnutris sous traitement les incombe également ;
- ✍ « Prise en charge ambulatoire pour les enfants âgés de 6 à 59 mois malnutris sans complications médicales » : ici, les enfants malnutris de cet âge visitent une fois par semaine le centre de santé (CS) ou les paramètres anthropométriques sont de nouveau évalués et le stock de plumpy nut est

renouvelé si pas de risque majeur, sinon l'enfant est référé dans un centre de prise en charge thérapeutique ;

- ✍ Prise en charge ambulatoire pour les enfants de 6 à 59 mois avec malnutrition aiguë modérée (MAM), cette composante prend en charge ce type d'enfants par des conseils nutritionnels et un suivi domiciliaire régulier par les relais communautaires ;
- ✍ « Prise en charge thérapeutique des enfants âgés de 0 à 59 mois malnutris avec complications médicales » la prise en charge se fait par hospitalisation des malnutris avec complications médicales. Ce volet prend également en compte les enfants de la tranche 0 à 5 mois souffrant des problèmes nutritionnels et ceux âgés de 6 à 59 dont la malnutrition est associée à des complications médicales.

L'expérience de cette prise en charge communautaire de la malnutrition faite en Afrique Subsaharienne, a été concluante avec l'amélioration des taux de guérison et de la réduction des taux de décès au Ghana, Malawi, et Zambie en 2014 [24].

2.2.3 Indicateurs de performance des centres de prise en charge de la malnutrition

Le tableau ci-dessous nous permet d'apprécier les centres de nutritionnels à partir des indicateurs de performance de la prise en charge de la malnutrition aiguë qui y figurent.

Tableau I : Indicateurs de performance des centres de prise charge de la malnutrition

Indicateurs	Acceptable (performance bonne)	Alarmant (perf. mauvaise)
Taux de guérison	> 75%	< 50%
Taux de létalité	<10%	> 15%
Taux d'abandon	< 15%	> 25%
Gain de poids moyen	≥8g /kg/jour	< 8g /kg/jour
Durée moyenne de séjour	< 4 semaines	> 6 semaines
Taux de couverture	> 60 %	> 40%

Source : Protocole national de prise en charge du Bénin, 2011

2.3 Revue de littérature

2.3.1 Composante « Structure »

Some Y et al., ont réalisé en 2017 une étude sur l'évaluation de la gestion des intrants nutritionnels pour la prise en charge de la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans dans les formations sanitaires de la région du Centre au Burkina. Dans plus de 85% des CSPS/CM, les équipements techniques nécessaires au stockage des intrants nutritionnels étaient quasi-inexistants. Ils ont aussi constaté un stock insuffisant avec les ruptures constatées de certains intrants traceurs comme le plumpy nut et l'amoxicilline au cours du premier trimestre de cette année. Les outils de gestion de stock disponibles étaient irrégulièrement tenus à jour [25].

Paraiso MN et al., ont mené aussi en 2014 une étude sur l'évaluation de la performance de la prise en charge de la malnutrition aiguë en ambulatoire chez les enfants de moins de 5 ans dans le Nord du Bénin. La disponibilité en ressources humaines était « Bonne ». La disponibilité des outils de suivi et d'évaluation était satisfaisante. Les boîtes à images n'étaient pas suffisantes. Les centres de prise en charge de MAS n'avaient pas d'équipement de démonstration culinaire.

Globalement, la « sous-composante ressource » avait été notée « acceptable » à 73,52 % [26].

Kenao TS et al., ont mené en 2016, une étude transversale descriptive sur la qualité de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans malnutris aigus sévères du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Départemental (CHD) Mono à Lokossa au Bénin. Cette étude qui a pris en compte 27 enfants malnutris internés de janvier à décembre 2015, avait noté que le score de qualité des intrants pour la prise en charge des malnutris était faible (25%) [27].

2.3.2 Composante « Processus »

Dans la même étude qu’ont mené Kenao TS et al., en 2016, au service de pédiatrie du Centre Hospitalier Départemental (CHD) Mono à Lokossa au Bénin, supervision du personnel était faible (25%) [27].

2.3.3 Composante « Résultats »

Le partenaire privilégié UNICEF avait financé plusieurs pays dans la lutte contre la malnutrition au niveau communautaire. Ce financement était suivi des évaluations afin d’apprécier la performance de ce programme. Dans ce cadre, une étude était menée par Jayatissa R. et al ; en Sri Lanka sur l’impact du programme de réhabilitation nutritionnelle au niveau communautaire a révélé que la prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de cinq ans est passée de 18% à 9,60%, une réduction de 47%, tandis que la prévalence de la malnutrition aiguë sévère a chuté de 3,5% à 0,7%, soit une réduction de 80% [28].

Une étude menée au CHU Sourou Sanou, Bobo-Dioulasso par Sanogo Bintou et al., a montré que les enfants sévèrement émaciés ont un risque de décès douze fois plus élevé que leurs homologues [29].

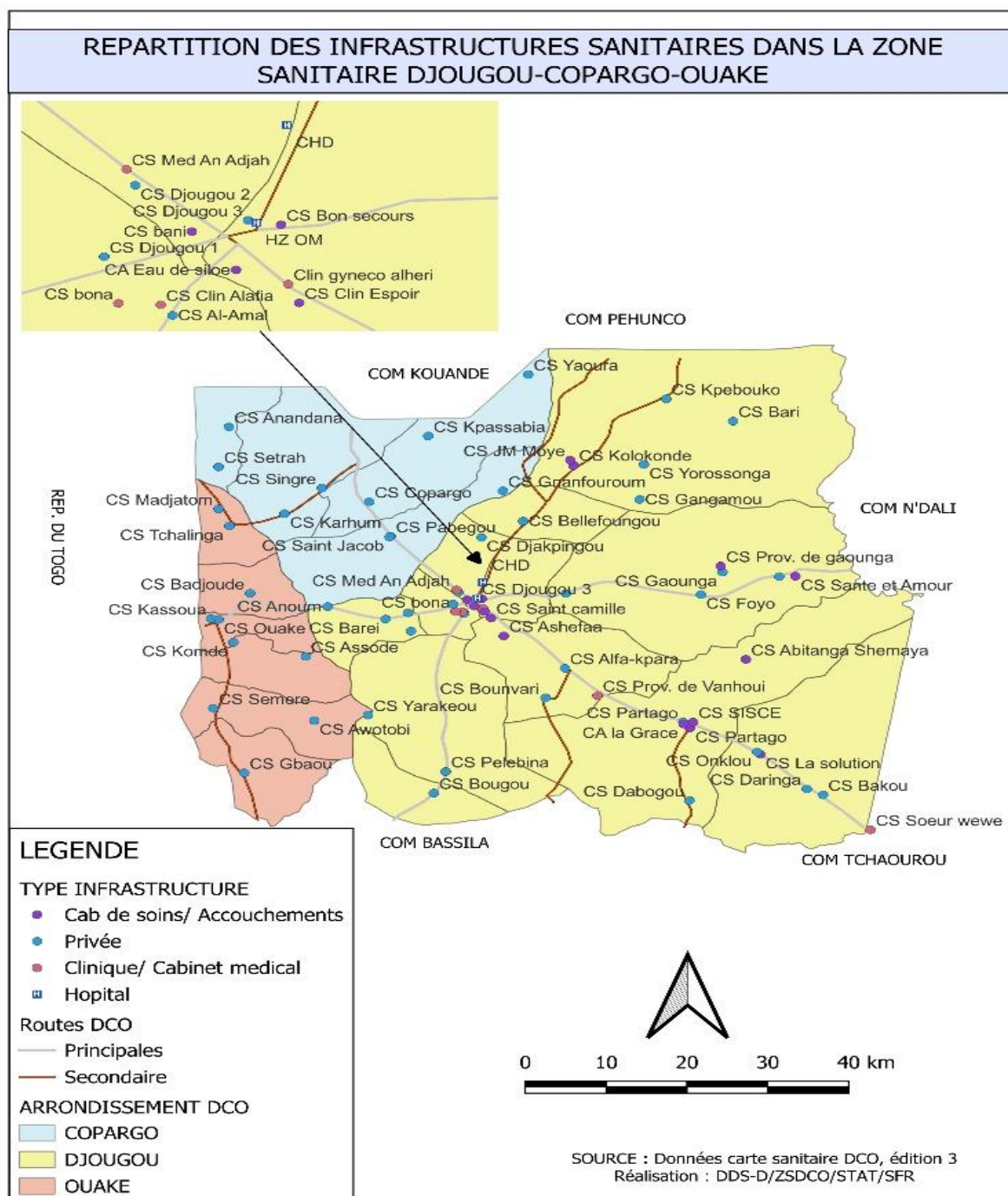
Desyibelew FD et al., ont mené en 2017 une étude sur le taux de guérison et les facteurs associés chez les enfants âgés de 6 à 59 mois admis pour malnutrition aiguë sévère dans l'unité d'hospitalisation de Bahir Dar Felege Hiwot, Hôpital du Nord-Ouest de l'Ethiopie. Cette étude a concerné un total de 401 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et admis dans les unités d'alimentation thérapeutique entre septembre 2012 et janvier 2016. Les enfants de sexe masculin représentaient 55,60%. Plus de la moitié (63,1%) des enfants souffraient d'émaciation grave sans œdèmes [30].

3. METHODES D'ETUDE

3.1 Cadre d'étude

3.1.1 Situation géographique

La zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké est limitée : au Nord par les communes de Kouandé et de Péhunco, au Sud par les communes de Bassila et Tchaourou, à l'Est par la commune de N'Dali et à l'Ouest par la République du Togo [31].



Source : Données carte sanitaire DCO, édition 3, 2024

Rédaction-D/ZSDCO/STAT/SFR

Figure 2 : Carte géographique de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké

3.1.2 Caractéristiques démographiques

En 2024, la population de la zone sanitaire était de **532.771** habitants avec une densité 97 habitants/km². Les enfants de 0 à 59 mois représentaient 16,87% soit 89 900.

3.1.3 Aspects socio-culturels et économiques

Les ethnies les plus dominantes sont les Yom et Lokpa représentant près de 80% de la population. Parlant de la religion, la plus populaire était l'Islam avec environ 81% suivi de la religion Catholique. Dans la plupart du temps les femmes sont données en mariage conformément à leur coutume. Le mariage polygame est autorisé. La population est en majorité analphabète. La religion interdisant la planification familiale (PF), laissait observer un nombre pléthorique d'enfants dans la plupart des ménages [32].

L'exode rural est le maître mot dans cette contrée du Bénin.

L'économie était basée sur l'agriculture, l'élevage et le commerce.

L'habitude alimentaire était basée sur la consommation de l'ignames pilées et la pâte qui étaient rarement variées surtout en zone rurale.

Notons au passage que les cultures maraichères et les fruits étaient rares et étaient importés du sud du pays et des pays voisins comme Togo et Niger.

3.1.4 Aspects administratifs

Administrativement, le préfet est le représentant du pouvoir central. En dessous de ce dernier, se trouvent les maires et ses conseillers qui sont les représentant de la population. Le territoire est découpé en préfecture, 03 Communes, 22 arrondissements et 229 villages et quartiers de ville.

3.1.5 Données sanitaires

La Zone Sanitaire couvre une superficie de 5 465 km². L'accessibilité géographique était de 75%, avec sept formations sanitaires situées à plus de 10 km. La ZS est composée de 51 Centres de Santé publics et 19 CS privés reconnus. Elle couvre trois centres de santé communaux, un hôpital de zone, un Bureau de zone coiffé par un médecin Coordonnateur, aidée dans ses tâches par les membres de l'Equipe d'Encadrement de Zone (EEZ).

3.1.6 Consultations curatives

Taux de fréquentation : 55% contre 60% l'objectif pays.

Les cinq premières causes de consultation en général étaient : Paludisme toute forme (45%), IRA basse (11%), Affections gastro-intestinales (7%), Diarrhées (4%), Infections respiratoires hautes (3%).

3.2 Type et période d'étude

Il s'est agi d'une étude transversale et évaluative. Cette étude s'était déroulée durant la période de janvier en juillet 2025 et dans le cadre de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké.

3.3 Population d'étude

3.3.1 Populations cible

Cibles primaires

- ✍ Centres nutritionnels ambulatoires et
- ✍ Centres nutritionnels thérapeutiques

Cibles secondaires

Nos cibles secondaires étaient constituées par :

- ✍ Les prestataires de prise en charge MAS,
- ✍ Les Relais Communautaires
- ✍ Les malnutris

3.4 Critères de sélection

Critères d'inclusion

Etaient inclus dans cette étude les cibles répondant aux critères suivants :

- ✍ Être un centre nutritionnel ambulatoire ou centre nutritionnel thérapeutique public ou parapublic reconnu par légalement ;
- ✍ Être un prestataire impliqué dans la prise en charge et présent lors de l'enquête ;
- ✍ Être un relai communautaire impliqué dans la prise en charge et présent lors de l'enquête ;
- ✍ Être un malnutri admis dans l'un des centres nutritionnels impliqués en 2024

3.5 Méthode et techniques d'échantillonnage

3.5.1 Méthode d'échantillonnage

La méthode d'échantillonnage était non probabiliste pour les toutes cibles.

3.5.2 Techniques d'échantillonnage

Tableau II : Techniques d'échantillonnage

Cibles	Techniques d'échantillonnage
Centres nutritionnels CNA/CNT	Choix exhaustif
Agents de santé	Choix raisonné
Relais Communautaires	Choix raisonné

Cibles	Techniques d'échantillonnage
Enfants malnutris	Recensement exhaustif des malnutris dans les CNA et CNT

3.5.3 Taille de l'échantillon

Le tableau ci-dessous présente les différentes structures en fonction des cibles et de leurs effectifs dans les CNA et CNT en 2024.

Tableau III : Structures en fonction des cibles et de leurs effectifs aux CNA et CNT en 2024

Structure	Cibles	Effectifs
	Nutritionniste responsable du service	2
Centres nutritionnels thérapeutiques	Enfants malnutris avec complications médicales	25
	Agents de santé impliqués dans la PEC	4
Centres nutritionnels ambulatoires	Enfants malnutris sans complications médicales	215
	Agents impliqués dans la PEC	43
Communauté	Relais communautaires	43
Bureau de Zone	Point Focal Nutrition	1

3.6 Les variables d'étude

La variable dépendante d'étude était la performance des CNA et CNT de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké. Elle était expliquée par trois composantes indépendantes : la structure, le processus et les résultats

3.7 Aspects opérationnels des variables

Nous avons rendu opérationnel les sous-composantes des composantes indépendantes à travers l'attribution des scores pour apprécier chaque composante. La composante principale a été appréciée en sommant les scores des trois composantes.

Modalités et critères de cotation

Nous avons présenté les aspects opérationnels des variables à travers la définition de critères et l'attribution d'un score pour apprécier ces différents critères. Pour ce faire, chaque variable des trois composantes du cadre conceptuel : « Structure de prise en charge », « Processus de prise en charge » et « Résultats » s'était vue attribuée un score selon que le critère était présent ou absent.

Tableau IV : Modalités et critères de cotation

Modalité	Oui	Non
Importance du critère		
Majeur	2	
Mineur	1	
Critère absent		0

La somme des scores des différents critères était égale au score final pour chaque composante à partir duquel, nous avons apprécié globalement la composante.

Une évaluation à trois échelles était adoptée pour apprécier ces trois composantes : « Structure », « Processus » et « Résultats » sur la base de l'échelle de mesure de Varkevisser comme référence [33].

Ainsi la performance de la composante était jugée :

- ✍ « Bonne » si le score obtenu était compris entre [80 - 100 %] ;
- ✍ « Moyenne » si le score obtenu était compris entre [60 - 80 %] ;
- ✍ « Faible » si le score obtenu était compris entre [0 - 60 %] .

3.7.1 Aspects opérationnels des variables des CNA

Les tableaux IV à VI ci-après présentent en détail les aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « structure », « processus » et « résultats ». Le tableau VII présente la synthèse des scores attendus par composante.

Tableau IV : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « structure de la prise en charges » dans les CNA de la ZS DCO en 2025

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Scores attendus	Observations
Disponibilité des ressources humaines	Personnel qualifié formé	Personne impliquée dans la prise en charge ayant un renforcement de capacité sur la malnutrition	Oui=2 Non=0	La formation est capitale pour avoir une compétence technique dans la prise en charge MAS
	Relai communautaire formé	Personne identifiée dans la communauté et formé sur la prise en charge de la malnutrition	Oui=1 Non=0	
Score total disponibilité des ressources humaines (A)			(43*2) + (43*1) =129	43 CNA

Tableau V : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « structure de la prise en charges » dans les CNA de la ZS DCO en 2025 **(Suite)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Scores attendus	Observations
Disponibilité de ressources matérielles	Toise	La toise est disponible et utilisable	Oui=1 Non=0	
	Pèse-personnes	Au moins une balance pèse-personnes est disponible et fonctionnelle	Oui=1 Non=0	
	Pèse-bébé/balance Salter	Au moins une balance est disponible et fonctionnelle	Oui=1 Non=0	
	Bandelettes à couleurs	Les bandelettes à couleurs sont disponibles et utilisables	Oui=1 Non=0	
	Boites à images	Les boites à image sont disponibles et non défectueuses	Oui=1 Non=0	
	Matériel culinaire	Le matériel culinaire est disponible et utilisable	Oui=1 Non=0	Marmites, foyer
Score total disponibilité des ressources matérielles (B)			(43*1*6) =258	

Tableau VI : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « structure de la prise en charges » dans les CNA de la ZS DCO en 2025 **(Suite)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Scores attendus	Observations
Disponibilité des ressources informationnelles	Protocole de prise en charge	Le protocole est disponible physiquement	Oui=2 Non=0	Outil de base de la PEC
	Registre de prise en charge	Le registre est disponible	Oui=1 Non=0	
	Fiches de suivi	Fiches de suivi vierges au moins sont disponibles	Oui=1 Non=0	
	Fiches de stock	Fiches de stock vierges au moins sont disponibles	Oui=1 Non=0	
Score total disponibilité des ressources informationnelles (C)			(43*1*5) + (43*2) =215	

Tableau VII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « structure de la prise en charges » dans les CNA de la ZS DCO en 2025 (Suite et fin)

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Scores attendus	Observations
Disponibilité des intrants	Albendazole	La disponibilité de l'Albendazole est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Amoxicilline	La disponibilité de l'Amoxicilline est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Fer Acide Folique	La disponibilité du Fer Acide Folique est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Vitamine A	La disponibilité de Vitamine A est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Plumpy nut	La disponibilité de Plumpy nut est d'au moins 11 mois	Oui=2 Non=0	Indispensable pour CNA
	ReSoMal	La disponibilité de ReSoMal est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
Score total disponibilité de la disponibilité des intrants (D)			(43*2) + (43*1*5) =301	
Score total de la composante « Structure »			903	A+B+C+D

Tableau VIII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charge » dans les CNA la ZS DCO en 2025

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspects opérationnels des dimensions	Scores attendus	Observations
Dépistage et prise en charge	Accueil	Les enfants et leurs parents ont reçu la bienvenue du prestataire et un siège leur offert	Oui=1 Non=0	Le dépistage précoce est indispensable pour réduire les incidences
	Dépistage passif systématique	Les paramètres anthropométriques sont pris chez chaque enfant de moins de cinq ans reçus en consultation	Oui=2 Non=0	
	Dépistage actif	Disponibilité d'un cahier de stratégie avancée avec liste des enfants	Oui=2 Non=0	
	Remplissage correcte des supports	Tous les items sont renseignés	Oui=1 Non=0	
	Traitement diététique	Respect du traitement selon le protocole	Oui=2 Non=0	
Score total dépistage et prise en charge (E)			(43*2*3) + (43*1*2) =344	

Tableau IXI : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charges » dans les CNA la ZS DCO en 2025 **(Suite)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspects opérationnels des dimensions	Scores attendus	Observations
Système de Suivi des malnutris	Fonctionnalité du système RCR	Les fiches de référence contre référence sont disponibles	Oui=1 Non=0	
	Suivi des malnutris dans la communauté	Disponibilité des rapports d'activités des relais communautaires	Oui=1 Non=0	
Score total Système de Suivi des malnutris (F)			(43*1*2) =86	

Tableau XI : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charges » dans les CNA la ZS DCO en 2025 **(Suite)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspects opérationnels des dimensions	Scores attendus	Observations
Sensibilisation	Causeries éducatives nutritionnelles	Un cahier de causeries éducatives renseignant les thèmes est disponible	Oui=1 Non=0	
	Démonstration culinaire	Un cahier de causeries éducatives renseignant les thèmes est disponible	Oui=1 Non=0	
Score total sensibilisation (G)			(43*1*2) =86	

Tableau XII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charges » dans les CNA la ZS DCO en 2025 **(Suite et fin)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspects opérationnels des dimensions	Scores attendus	Observations
Coordination	Elaboration de rapport	Disponibilité des rapports mensuels d'activités de toute l'année 2024	Oui=1 Non=0	
	Supervision	Disponibilité de cahier de supervision avec au moins une par semestre	Oui=1 Non=0	
Score total coordination (H)			(43*1*2) =86	
Score total composante « Processus »			559	E+F+G+H

Tableau XIII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « résultats de la prise en charge » dans les CNA de la ZS DCO en 2025

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score	Observation
Taux de guérison	Les malnutris guéris	Le taux de rapport entre les malnutris guéris et les malnutris sortis est supérieur à 75%	Oui=2 Non=0	Indicateurs clés qui traduisent la gravité de la malnutrition
Taux de létalité	Les malnutris décédés	Le taux de rapport entre les malnutris décédés et les sorties est inférieur à 10%	Oui=2 Non=0	
Taux d'abandon	Les malnutris perdus de vue	Le taux de rapport entre les malnutris non répondant et les sorties est inférieur à 15%	Oui=1 Non=0	

Tableau XIII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « résultats de la prise en charge » dans les CNA dans la ZS DCO en 2025 (**Suite et fin**)

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score	Observation
Gain de poids moyen	Poids des enfants malnutris guéris	La valeur du gain journalier de poids des enfants sortis guéris est supérieure à 8g/kg/j	Oui=1 Non=0	
Durée moyenne de séjour	Temps passé par les malnutris dans les centres de prise en charge	Le temps de séjour pendant la prise en charge est inférieur à 4 semaines	Oui=1 Non=0	
Taux de couverture	Cible de la malnutrition attendue	Le taux de rapport entre les malnutris dépistés et la cible attendue est supérieure à 60%	Oui=1 Non=0	
Score total de la composante « résultats »			(43*2*2) + (43*1*3) =344	

Tableau XIVI : Synthèse des aspects opérationnels des composantes « structure » , « processus » et « résultats » dans les CNA de la ZS DCO en 2025

Composante	Score attendu	Si score obtenu est	%	Appréciation de le performance
Structure	903	723 à 903	[80-100]	Cote A : Bonne
		533 à 722	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 532	[0-60[	Cote C : Faible
Processus	559	448 à 559	[80-100]	Cote A : Bonne
		330 à 447	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 329	[0-60[	Cote C : Faible

Tableau XVI : Synthèse des aspects opérationnels des composantes « structure », « processus » et « structure » dans les CNA de la ZS DCO en 2025 (Suite et fin)

Composante	Score attendu	Si score obtenu est	%	Appréciation de le performance
Résultats	344	276 à 344	[80-100]	Cote A : Bonne
		203 à 275	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 202	[0-60[	Cote C : Faible
ZS DCO	1 806	1 445 à 1 806	[80-100]	Cote A : Bonne
		1 066 à 1 444	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 1 065	[0-60[	Cote C : Faible

La performance globale de la zone sanitaire DCO a été déduite de la somme des scores des trois composantes. Ainsi :

- ✍ La performance était jugée « Bonne », si le score compris entre 1 445 à 1 806 ;
- ✍ La performance était jugée « Moyenne », si le score compris entre 1 444 à 1 066 ;
- ✍ La performance était jugée « Faible », si le score compris entre 0 à 1 065.

3.7.2 Aspects opérationnels des variables dans les CNT

Les tableaux VIII à X ci-après présentent en détail les aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « structure », « processus » et « résultats ». Le tableau XI présente la synthèse des scores attendus.

Tableau IX : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « Structure de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score attendu	Observations
Disponibilité des ressources humaines	Présence d'un médecin pédiatre	Présence d'un médecin pédiatre dans le centre hospitalier de prise en charge MAS	Oui=2 Non=0	Ces deux types de personnel sont indispensables pour une meilleure PEC
	Présence d'un nutritionniste	Un agent nutritionniste est présent dans la structure de prise en charge	Oui=2 Non=0	
	Présence d'un collaborateur qualifié formé	Personne impliquée dans la prise en charge ayant un renforcement de capacité sur la malnutrition	Oui=1 Non=0	
Score total disponibilité des ressources humaines (A1)			(2*2*2) + (1*2*2) =12	2 CNT

Tableau IX : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « Structure de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025 **(Suite)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score attendu	Observations
Disponibilité des ressources matérielles	Toise	Une toise au moins est disponible et utilisable	Oui=1 Non=0	
	Pèse-personne	Au moins une balance pèse-personnes est disponible et fonctionnelle	Oui=1 Non=0	
	Pèse-bébé/balance Salter	Au moins une balance est disponible et fonctionnelle	Oui=1 Non=0	
	Bandelette tricolore	Les bandelettes à couleurs sont disponibles et utilisables	Oui=1 Non=0	
	Boites à images	Les boites à image sont disponibles et non défectueuses	Oui=1 Non=0	
	Matériel culinaire	Le matériel culinaire est disponible et utilisable	Oui=1 Non=0	
	Jeux d'enfants	Des jouets sont disponibles et mis à la disposition des malnutris	Oui=1 Non=0	
Score total de la disponibilité des ressources matérielles (B1)			(2*1*7) =14	

Tableau XVIX : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « Structure de la prise en charge» dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025 **(Suite)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score attendu	Observations
Disponibilité des ressources informationnelles	Protocole de prise en charge	Le protocole est disponible physiquement	Oui=2 Non=0	Le protocole est une nécessité pour suivre les directives
	Registre de prise en charge	Le registre est disponible	Oui=1 Non=0	
	Fiches de suivi	Fiches de suivi vierges au moins sont disponibles	Oui=1 Non=0	
	Fiches de stock	Fiches de stock vierges au moins sont disponibles	Oui=1 Non=0	
Score total de la disponibilité des ressources informationnelles (C1)			(2*2) + (2*1*3) =10	

Tableau XVIIX : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « Structure de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025 **(Suite et fin)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score attendu	Observations
Disponibilité des intrants	Albendazole	La disponibilité de l'Albendazole est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Amoxicilline	La disponibilité de l'Amoxicilline est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Fer Acide Folique	La disponibilité du Fer Acide Folique est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Vitamine A	La disponibilité de Vitamine A est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
	Plumpy nut	La disponibilité de Plumpy nut est d'au moins 11 mois	Oui=1 Non=0	
	F75	La disponibilité de F75 est d'au moins 11 mois	Oui=2 Non=0	F75 restaure les fonctions du malnutri
	F100	La disponibilité de F100 est d'au moins 11 mois	Oui=1 Non=0	
	ReSoMal	La disponibilité de ReSoMal est d'au moins trois trimestres	Oui=1 Non=0	
Score total de la disponibilité des intrants (D1)			(2*2) + (2*1*7) =18	
Score total de la composante « Structure »			54	A1+B1+C1+D1

Tableau XVIII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score attendu	Observations
Dépistage et prise en charge	Accueil	Les enfants et leurs parents ont reçu la bienvenue du prestataire et un siège leur offert	Oui=1 Non=0	
	Dépistage passif systématique	Les paramètres anthropométriques sont pris chez chaque enfant de moins de cinq ans reçus en consultation	Oui=2 Non=0	Il permet le dépistage précoce
	Dépistage actif	Disponibilité d'un cahier de stratégie avancée avec liste des enfants	Oui=1 Non=0	
	Traitement diététique	Respect du traitement selon le protocole	Oui=2 Non=0	
	Remplissage correcte des supports	Tous les items sont renseignés	Oui=1 Non=0	
Score total du dépistage et prise en charge (E1)			(2*2*2) + (2*1*3) =14	

Tableau XIX : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025 **(Suite)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score attendu	Observations
Système de Suivi des malnutris	Visite médicale	Au moins une visite médicale est réalisée par jour et renseigné dans les dossiers des malnutris	Oui=2 Non=0	La visite est très importante pour évaluer l'état journalier de chaque malnutri
	Contrôle de la température	La température est prise deux fois par jour et renseignés dans les dossiers	Oui=1 Non=0	
	Fonctionnalité du système RCR	Les fiches de référence contre référence sont disponibles	Oui=1 Non=0	
	Suivi des malnutris dans la communauté	Disponibilité des données de suivi sur les rapports d'activités des relais communautaires	Oui=1 Non=0	
Score total du système de Suivi des malnutris (F1)			(2*2) + (2*1*3) =10	

Tableau XX : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « processus de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025 **(Suite et fin)**

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score attendu	Observations
Coordination	Elaboration de rapports d'activités	Disponibilité des rapports mensuels d'activités de toute l'année 2024	Oui=1 Non=0	
	Supervision	Disponibilité de cahier de supervision avec au moins une supervision par semestre	Oui=1 Non=0	
Score total de la coordination (G1)			(2*1*2) =4	
Sensibilisation	Causeries éducatives nutritionnelles	Un cahier de causeries éducatives renseignant les thèmes est disponible	Oui=1 Non=0	
	Démonstration culinaire	Un cahier de causeries éducatives renseignant les thèmes est disponible	Oui=1 Non=0	
Score total de la sensibilisation (H1)			(2*1*2) =4	
Score total de la composante « Processus »			32	E1+F1+G1+H1

Tableau XXII : Aspects opérationnels des sous-composantes de la composante « Résultats de la prise en charge » dans les centres nutritionnels thérapeutiques dans la ZS DCO en 2025

Sous-composante	Dimensions /Éléments constitutifs	Aspect opérationnel des dimensions	Score	Observation
Taux de guérison	Les malnutris guéris	Le taux de rapport entre les malnutris guéris et les malnutris sortis est supérieur à 75%	Oui=2 Non=0	Indicateurs clés qui traduisent la gravité de la malnutrition
Taux de létalité	Les malnutris décédés	Le taux de rapport entre les malnutris décédés et les sorties est inférieur à 10%	Oui=2 Non=0	
Taux d'abandon	Les malnutris perdus de vue	Le taux de rapport entre les malnutris non répondant et les sorties est inférieur à 15%	Oui=1 Non=0	
Gain de poids moyen	Poids des enfants malnutris guéris	La valeur du gain journalier de poids des enfants sortis guéris est supérieure à 8g/kg/j	Oui=1 Non=0	
Durée moyenne de séjour	Temps passé par les malnutris dans les centres de prise en charge	Le temps de séjour pendant la prise en charge est inférieur à 4 semaines	Oui=1 Non=0	
Taux de couverture	Cible de la malnutrition attendue	Le taux de rapport entre les malnutris dépistés et la cible attendue est supérieure à 60%	Oui=1 Non=0	
Score total de la composante « résultats »			(2*2*2) + (2*1*4) =16	

Tableau XXIII : Synthèse de l’appréciation des composantes « structure » et « processus » et « Résultats » dans les centres nutritionnels thérapeutiques de la ZS DCO en 2025

Composante	Score attendu	Si score obtenu est	%	Appréciation de le performance
Structure	54	44 à 54	[80-100]	Cote A : Bonne
		32 à 43	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 31	[0-60[	Cote C : Faible
Processus	32	26 à 31	[80-100]	Cote A : Bonne
		19 à 30	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 18	[0-60[	Cote C : Faible
Résultats	16	13 à16	[80-100]	Cote A : Bonne
		9 à 12	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 8	[0-60[	Cote C : Faible
ZS DCO	102	82 à 102	[80-100]	Cote A : Bonne
		61 à 81	[60-80[	Cote B : Moyenne
		0 à 60	[0-60[	Cote C : Faible

La performance globale de la zone sanitaire DCO a été déduite de la somme des scores des trois composantes. Ainsi si :

- ✍ La performance était jugée « Bonne », si le score était compris entre 82 et 102 ;
- ✍ La performance était jugée « Moyenne », si le score était compris entre 61 et 81 ;
- ✍ La performance était jugée « Faible », si le score était compris entre 0 et 60.

3.8. Techniques et outils de collecte

Les sources de données ont conditionné les techniques et outils utilisés. Nous avons utilisé quatre techniques résumées dans le tableau suivant :

Tableau XXIII : Techniques et outils utilisés pour la collecte des données dans la ZS DCO en 2025

Cibles/sources	Techniques	Outils
Agents de santé	Enquête par questionnaire	Questionnaire
Relais communautaires		
Gestionnaire des intrants	Entretien	Guide d’entretien
Outils de gestion CNA/CNT	Exploitation de documents	Fiches de dépouillement
Enfants malnutris	Observation	Grille d’observation

3.9 Période de collecte

La collecte des données a été effectuée du 24 mars au 05 avril 2025 soit 12 jours. Cette collecte a été menée par trois enquêteurs.

3.10 Plan de traitement et d'analyse des données

3.10.1 Traitement des données

Les données ont été exportées sous le format Excel de la plate-forme KoBoToolBox à la suite de leur collecte. Lesdites données ont été vérifiées par rapport à leur exhaustivité et leur complétude pour des raisons d'ajustement.

3.10.2 Analyse des données

L'analyse des données, a été faite par objectif spécifique.

Cette analyse a été faite en deux temps. Une première partie a pris en compte l'analyse descriptive et une deuxième consacrée à la phase analytique. Le logiciel Microsoft Excel Version 2016 a servi de base d'analyse pour notre étude.

La description de la composante « Structure », « Processus » et « Résultats » s'est faite par des proportions.

L'appréciation du niveau de performance s'est faite par sous-composante, par composante puis leur résultante globale a donné la performance de la zone sanitaire.

3.10.3 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM)

Notre analyse a été complétée par une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM). Ainsi, nous avons surtout dégagé les faiblesses et les menaces qui constituent des obstacles des centres nutritionnels à une meilleure prise en charge de la malnutrition.

3.10.4 Diagramme d'Ishikawa des causes probables des faiblesses

A partir des faiblesses, nous allons proposer un diagramme d'Ishikawa pour ressortir les causes probables d'une part des CNA et d'autre part des CNT

3.11 Aspects éthiques et déontologiques

Administrativement, les responsables sanitaires de zone en particulier le médecin coordonnateur et sa suite étaient informés par correspondance de la tenue de notre étude dans leur localité. Les populations étaient informées de la collecte au moins 24 heures avant. Les participants étaient également informés du motif et les retombées de cette enquête pour la communauté. Ils ont été aussi informés que l'enquête sera anonyme, confidentielle et ne va leur porter aucun préjudice. Les enquêteurs portaient des badges.

Les résultants seront partagés avec les responsables de zone sanitaire après leur validation par les membres de jury à la soutenance de ce mémoire.

3.12 Style de référence

Les références ont été rédigées selon la norme de la convention de Vancouver et présentées suivant leur ordre chronologique d'apparition dans ce document.

4. RESULTATS

Rappelons ici que les résultats de notre étude ont été présentés par objectif spécifique après la description des diverses populations étudiées.

Ces résultats sont structurés en trois grandes parties. Il s'agit de point de l'enquête, la description des composantes de l'étude et la partie analytique qui a pris en compte l'appréciation des composantes explicatives, de la composante principale.

4.1 Description des composantes « structure », « processus » et « résultats »

4.1.1 Description des éléments de la « structure »

4.1.1.1 Sous-composante « ressources humaines »

Tableau XIV : Cibles d'étude associée à l'âge moyen, le sexe et le niveau d'étude

Cibles	Age moyen	Sexe plus représenté	Niveau d'étude plus représenté
Prestataires	36,43 ± 9,00 ans	Féminin (62,69%)	Secondaire (44,44%)
Enfants malnutris	14 mois (10 ; 21)	Féminin (52,50%)	
Relais communautaire	36,43 ± 9,00 ans	Masculin (83,72%)	Secondaire (71,11%)

Parmi ces prestataires, seulement 6 ont été formés soit 13,95% sur l'ensemble des centres de prises en charge de la malnutrition.

Au niveau des centres nutritionnels thérapeutiques, les prestataires impliqués étaient à 100% formés. Cependant, un des deux CNT ne disposait pas de médecin pédiatre.

Tableau XV : Présentation des résultats de la sous-composante « ressources humaines » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Élément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
	Personnel formé	86	12	2	2
Disponibilité des ressources humaines	Relais communautaires	43	43		
	Médecin pédiatre			4	2
	Nutritionniste			4	4
Score total des ressources humaines		129	55	10	8

NB :  Rubriques non évaluées selon le type de CREN

- ✍ CNA : sur un score total attendu 129, le score de la disponibilité des ressources humaines était de 55, soit 42,63%.
- ✍ CNT : sur un score total attendu 10, le score de la disponibilité des ressources humaines était de 8, soit 80%.
- ✍ Le personnel formé était de 13,95%

4.1.1.2 Sous-composante « ressources matérielles »

Tableau XXIV : Présentation des résultats de la sous-composante « ressources matérielles » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Elément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Disponibilité des ressources matérielles	Toise	43	41	2	2
	Pèse-personnes	43	43	2	2
	Pèse-bébé/balance	43	42	2	2
	Salter	43	42	2	2
	Bandelette tricolore (MUAC)	43	42	2	2
	Boîtes à images	43	41	2	2
	Matériel culinaire	43	7	2	2
	Jeux d'enfants			2	1
Score total de la disponibilité des ressources matérielles		258	216	14	13

NB : Rubriques non évaluées selon le type de CREN

- ✍ CNA : sur un score total attendu 258, le score de la disponibilité des ressources matérielles était de 216, soit 83,72%.
- ✍ CNT : sur un score total attendu 14, le score de la disponibilité des ressources humaines était de 13, soit 92,86%.
- ✍ La disponibilité du matériel culinaire était de 16,28%

4.1.1.3 Sous-composante « ressources informationnelles »

Tableau XXVII : Présentation des résultats de la sous-composante « ressources informationnelles » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Elément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Disponibilité des ressources informationnelles	Protocole de prise en charge	86	46	4	4
	Registre de prise en charge	43	42	2	2
	Fiches de suivi	43	40	2	2
	Fiches de stock	43	12	2	2
Score total de la disponibilité des ressources informationnelles		215	140	10	10

- ✍ CNA : sur un score total attendu 215, le score de la disponibilité des ressources informationnelles était de 140, soit 65,12%.
- ✍ CNT : sur un score total attendu 10, le score de la disponibilité des ressources humaines était de 10, soit 100%
- ✍ Le remplissage correct des fiches de stock était de 27,91%

4.1.1.4 Sous-composante disponibilité des « intrants »

Tableau XXVIII : Présentation des résultats de la sous-composante « Disponibilité des intrants » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Élément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Disponibilité des intrants	Plumpy nut	86	74	2	2
	F75			4	0
	F100			2	2
	ReSoMal	43	26	2	2
	Albendazol	43	17	2	0
	Amoxicilline	43	21	2	0
	Fer Acide Folique)	43	11	2	0
	Vitamine A	43	36	2	2
Score total disponibilité des intrants		301	185	18	8

NB :  Rubriques non évaluées selon le type de CREN

- ✍ CNA : Sur un score total attendu 301, le score de la disponibilité des ressources informationnelles était de 185, soit 61,46%.
- ✍ CNT : Sur un score total attendu 18, le score de la disponibilité des « intrants » était de 8, soit 44,44%.

4.1.2 Synthèse des résultats de la composante « Structure » des CNA/CNT en 2025

Tableau XXVIIX : Synthèse des résultats de la composante « Structure » des CNA/CNT en 2025

Sous-composante	CNA		CNT	
	Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Ressources humaines	129	55	10	8
Ressources matérielles	258	216	14	13
Ressources informationnelles	215	140	10	10
Disponibilité des intrants	301	185	18	8
Total	903	596	52	39

La somme des différentes sous-composantes nous a permis d'obtenir les résultats de la composantes « Structure » selon la nature du type de CREN.

✍ CNA : sur un score total attendu 903, le score de la composante « Structure » était de 596, soit 66%.

✍ CNT : sur un score total attendu 52, le score de la composante « Structure » était de 39 soit 75%.

4.1.3 Description des éléments du « Processus »

4.1.3.1 Sous-composante « dépistage et prise en charge »

Tableau XX : Présentation des résultats de la sous-composante « Dépistage et prise en charge » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Élément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Dépistage et prise en charge	Accueil	43	41	2	2
	Dépistage passif systématique	86	86	4	4
	Dépistage actif	86	86	2	2
	Traitement diététique	86	64	4	4
	Remplissage correcte des supports	43	26	2	2
Score total dépistage et prise en charge		344	303	14	14

- ✍ CNA : sur un score total attendu 344, le score de « Dépistage et prise en charge » était de 303, soit 88,08%.
- ✍ CNT : sur un score total attendu 14, le score de « Dépistage et prise en charge » était de 14, soit 100%.
- ✍ Le remplissage correct des supports était de 56,52%

4.1.3.2 Sous-composante « système de suivi » des malnutris

Tableau XXVIII : Présentation des résultats de la sous-composante « système de suivi des malnutris » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Elément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Système de suivi des malnutris	Visite médicale			4	4
	Contrôle de la température			2	2
	Fonctionnalité du système RCR	43	41	2	2
	Suivi des MAS dans la communauté	43	41	2	2
Score total système de suivi des malnutris		86	82	10	10

NB :  Rubriques non évaluées selon le type de CREN

✍ CNA : sur un score total attendu 86, le score de « Système de suivi des malnutris » était de 82, soit 95,35%.

✍ CNT : sur un score total attendu 10, le score de « Système de suivi des malnutris » était de 10, soit 100%.

4.1.3.3 Sous-composante « coordination »

Tableau XXIXII : Présentation des résultats de la sous-composante « Coordination » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Elément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Coordination	Elaboration des rapports d'activités	43	42	2	2
	Supervision	43	42	2	2
Score total de la sous-composante coordination		86	84	4	4

✍ CNA : sur un score total attendu 86, le score de « Coordination » était de 84, soit 97,67%.

✍ CNT : sur un score total attendu 4, le score de « Coordination » était de 4, soit 100%.

4.1.3.4 Sous-composante « sensibilisation »

Tableau XXXII : Présentation des résultats de la sous-composante « Sensibilisation » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composante	Élément de la sous-composante	CNA		CNT	
		Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Sensibilisation	Causerie éducative	43	43	2	2
	Démonstration culinaire	43	16	2	2
Score total sous-composante sensibilisation		86	59	4	4

✍ CNA : sur un score total attendu 86, le score de la « sensibilisation » était de 59, soit 68,60%.

✍ CNT : sur un score total attendu 4, le score de « sensibilisation » était de 4, soit 100%

✍ La démonstration culinaire était 68,60%

4.1.3.5 Synthèse des résultats de la composante « Processus » des CNA/CNT en 2025.

Tableau XXIV : Synthèse des résultats de la composante « Processus » des CNA/CNT en 2025

Sous-composante	CNA		CNT	
	Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Dépistage et prise en charge	344	303	14	14
Système de suivi des malnutris	86	82	10	10
Coordination	86	84	4	4
Sensibilisation	86	59	4	4
Total	602	528	32	32

- ✍ CNA : sur un score total attendu 602, le score de la composante « Processus » était de 528, soit 87,70.
- ✍ CNT : sur un score total attendu 32, le score de la composante « Structure » était de 32 soit 100%.

4.2 Présentation des résultats par centre de prise en charge de la malnutrition

4.2.1 Présentation des « résultats » de la prise en charge de la malnutrition par commune dans les CNA en 2025

Tableau XXV : Présentation des « Résultats » de la prise en charge MAS par commune dans les CNA en 2025

Centre de Santé	Taux de guérison	Taux de létalité	Taux d'abandon	Gain de poids moyen	Durée moyenne de séjour	Taux de couverture
Commune de Copargo						
ANANDANA	100	0	0	4	28	95,1
COPARGO CENTRE	100	0	0	16	25	59
GNANFOUROM	100	0	0	13	29	80
KARHOUM	100	0	0	9	37	90,6
KPASSABIA	100	0	0	9	21	83,1
PABEGOU	180,3	0	0	5	28	55,5
SETRAH	100	0	0	9	21	60
SINGRE	100	0	0	7	28	61
YAOURA	0	0	0	6	22	94,5

Tableau XXXIV : Présentation des « Résultats » de la prise en charge MAS par commune dans les CNA en 2025 (Suite)

Centre de Santé	Taux de guérison	Taux de létalité	Taux d'abandon	Gain de poids moyen	Durée moyenne de séjour	Taux de couverture
Commune de Djougou						
ALFA KPARA	137,3	0	0	0	28	72,8
ANOUM	100	0	0	9	34	78,1
BAKOU	100	0	0	9	21	23,2
BAREI	91,3	0	8,7	8	29	20,7
BARI	100	0	0	4	38	111,1
BARIENOU	100	0	0	3	32	40,2
BELLEFOUNGOU	66,7	0	33,3	10	24	27,3
BOUGOU	100	0	0	17	36	52,8
BOUNVARI	50	0	0	7	23	17,6
DABOGOU	100	0	0	6	21	34,9
DARINGA	100	0	0	21	20	11,6
DJAKPINGOU	100	0	0	18	28	42,9
DJOUGOU 1	100	0	0	9	29	21,3

Tableau XXV : Présentation des « Résultats » de la prise en charge MAS par commune dans les CNA en 2025 (Suite)

Centre de Santé	Taux de guérison	Taux de létalité	Taux d'abandon	Gain de poids moyen	Durée moyenne de séjour	Taux de couverture
Commune de Djougou						
DJOUGOU 2	100	0	0	8	29	35,5
DJOUGOU 3	100	0	0	13	26	33,6
FOUNGA	100	0	0	15	28	112
FOYO	100	0	0	13	36	56,3
GANGAMOU	100	0	0	9	25	100
GAOUNGA	100	0	0	21	29	56
KOLOKONDE	100	0	0	22	19	41
ONKLOU	100	0	0	15	26	17
PARTAGO	100	0	0	12	28	35,1
PELEBINA	100	0	0	12	28	4,6
TOKOTOKO	65,2	0	34,8	13	30	19,3
YOROSONGA	158,8	0	0	7	30	63

Tableau XXV : Présentation des « Résultats » de la prise en charge MAS par commune dans les CNA en 2025 (Suite et fin)

Centre de Santé	Taux de guérison	Taux de létalité	Taux d'abandon	Gain de poids moyen	Durée moyenne de séjour	Taux de couverture
Commune de Ouaké						
ASSODE	100	0	0	6	28	58,6
AWOTOBI	114,3	0	7,1	3	33	82,4
BADJOUDE	98,4	0	0	12	27	45,7
GBAOU	100	0	0	29	29	44,6
KASSOUA	100	0	0	7	30	22,4
KOMDE	100	0	0	5	24	25,8
MADJATOM	100	0	0	3	23	94,1
SEMERE	100	0	0	9	34	18,9
TCHALINGA	100	0	0	6	31	50
Total CNA	99,1	0	2	10,2	27,8	52,3

En 2025, la prise en charge de la malnutrition dans les Centres de Nutrition Ambulatoire (CNA) de la Zone Sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké, le taux de guérison était 99,1 %, le taux de létalité était nul et le taux d’abandon (2 %). Le gain de poids moyen était 10,2 g/kg/j et la durée moyenne de séjour 27,8 jours. Toutefois, le taux de couverture était 52,3 %.

4.2.2 Présentation des résultats de la prise en charge de la malnutrition par commune dans les CNT en 2025

Tableau XXXIIVI : Présentation des « résultats » de la prise en charge de la malnutrition par commune dans les CNT en 2025

Centre de Santé	Taux de guérison	Taux de létalité	Taux d’abandon	Gain de poids moyen	Durée moyenne de séjour	Taux de couverture
OUAKE CENTRE (COMMUNE DE OUAKE)	100	0	0	21	21	16,9
HZ ORDRE DE MALTE (COMMUNE DE DJOUGOU)	86,7	3	16,3	11	13	88,6
Total CNT	93,3	1,5	8,2	15,9	17	52,7

En 2025, la prise en charge de la malnutrition dans les CNT des communes de Ouaké et Djougou a présenté les résultats : Le centre de Ouaké a affiché un taux de guérison 100 % avec zéro décès ni abandon. Le centre de Djougou a présenté un taux de guérison 86,7 % avec quelques cas de létalité (3 %) et d'abandon (16,3 %) avec un taux de couverture 88,6 %. Globalement, les CNT ont enregistré un taux de guérison de 93,3 % et un gain de poids moyen de 15,90 %, avec un taux de couverture global de 52,70 %.

4.2.3 Présentation des résultats de la composante « résultats » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Tableau XXXIIIIII : Présentation des résultats de la composante « résultats » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025

Sous-composantes	CNA		CNT	
	Score attendu	Score obtenu	Score attendu	Score obtenu
Taux de guérison	86	86	4	4
Taux de létalité	86	86	4	4
Taux d'abandon	43	43	2	2
Gain de poids moyen	43	43	2	2
Durée moyenne de séjour	43	43	2	2
Taux de couverture	43	0	2	0
Total composante résultats	344	301	16	14

✍ CNA : sur un score total attendu 344, le score obtenu de la composante « résultats » était de 301, soit 87,50%.

✍ CNT : sur un score total attendu 16, le score obtenu de la composante « résultats » était de 14, soit 87,50%

✍ Le taux de couverture était de 0% aux CNA et aux CNT

4.3 Appréciation globale de la composante principale à partir des composantes « structure », « processus » et « résultats »

Le tableau XXVIII ci-dessous présente la synthèse de l'appréciation de chaque composante « structure », « processus », « résultats » et de celle de la composante principale de cette étude.

4.3.1 Tableau XXVIII : Appréciation globale de la composante principale

Composantes	CREN	Score attendu	Score obtenu	%	Appréciation
Structure	CNA	903	596	66	Moyenne
	CNT	52	39	75	Moyenne
Processus	CNA	602	528	87,7	Bonne
	CNT	32	32	100	Bonne
Résultats	CNA	344	301	87,5	Bonne
	CNT	16	14	87,5	Bonne
Performance ZS-DCO	CNA	1806	1425	78,9	Moyenne
	CNT	102	85	83	Bonne

- ✍ Au total, sur un score attendu de 1 806, le score global obtenu était de 1 425 soit 78,90%, la performance était donc jugée « **Moyenne** » sur l'échelle de Varkevisser ;
- ✍ Sur un score attendu de 102, le score global obtenu était de 85 soit 83,83%, la performance était donc jugée « **Bonne** » sur la même échelle de Varkevisser.

4.4 Comparaison des résultats avec les normes du protocole national de prise en charge

Tableau XXIX : Comparaison des résultats avec les normes du protocole national de prise en charge

Sous-composantes	Réalisation au CNA (n=25)	Réalisation au CNT (n=215)	Seuil PECMA
Taux de guérison	99,1	93,30%%	> 75%
Taux de létalité	0	0,015	< 10%
Taux d'abandon	0,02	0,028	< 15%
Gain de poids moyen	10,2	15,9	≥ 8g/kg/j
Durée moyenne de séjour	27,8 jours	17	< 4 semaines
Taux de couverture	0,523	0,527	> 60%

Les performances des CNA et des CNT de la Zone Sanitaire DCO sont globalement satisfaisantes au regard des seuils fixés par le PECMA. Les taux de guérison sont très élevés (99,1 % au CNA et 93,3 % au CNT), bien au-dessus du seuil minimal de 75 %, ce qui témoigne de l'efficacité des prises en charge. Les taux de létalité (0 % au CNA et 1,5 % au CNT) et d'abandon (2 % au CNA et 2,8 % au CNT) étaient largement en dessous des seuils critiques, traduisant une bonne qualité des soins et une forte adhésion des patients au traitement. Le gain de poids moyen était aussi conforme aux attentes, avec 10,2 g/kg/j au CNA et 15,9 g/kg/j au CNT, dépassant le seuil de 8 g/kg/j. La durée moyenne de séjour était inférieure à 4 semaines. Cependant le taux de couverture était faible

dans les deux types de structures (52,3 % au CNA et 52,7 % au CNT), en dessous du seuil requis de 60 %. Ce qui met en évidence des efforts à faire pour améliorer la sensibilisation, le dépistage actif et l'accès aux soins dans la communauté.

4.5Analyse stratégique

4.5.1 Analyse des forces, faiblesse, opportunité, menaces (FFOM)

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de quelques forces, faiblesse, opportunité et menaces liées à la performance de CNA et CNT dans la prise en charge de la malnutrition à la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2025

Tableau XXX : Analyse de situation de la performance des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques avec l’outil d’Analyse FFOM

Composantes	Forces	Faiblesses	Opportunités	Menaces
Structure	• Disponibilité du matériel anthropométrique • Accessibilité du protocole de prise en charge • Implication des relais communautaires • Gratuité des intrants de prise en charge	• Formation insuffisante du personnel • Rupture fréquente des intrants (Albendazole, Amoxicilline, FAF...)	• Disponibilité de l’Etat (MS), partenaires financiers (UNICEF) et les ONG • Possibilité de nouer des partenariats avec les autres zones sanitaires	• Impact de la situation socio-économique des populations • Crise et instabilité politique du pays (Fermeture des frontières) • Insécurité alimentaire • Poids des us et coutumes
Processus	• Fonctionnalité des types de dépistage • Système référence contre référence fonctionnel et dynamique • Disponibilité des rapports d’activités	• Supports de prise en charge non ajour • Insuffisance des démonstrations culinaires	• Possibilité d’impliquer les leaders communautaires dans le dépistage	

Résultats	• Taux de guérison très élevé • Taux de létalité très faible • Bon gain de poids journalier	• Faible couverture de la cible MAS	• Possibilité de nouer de nouveaux partenariats avec des ONG	
------------------	---	---	--	--

4.5.2 Digramme d'ISHIKAWA des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNA

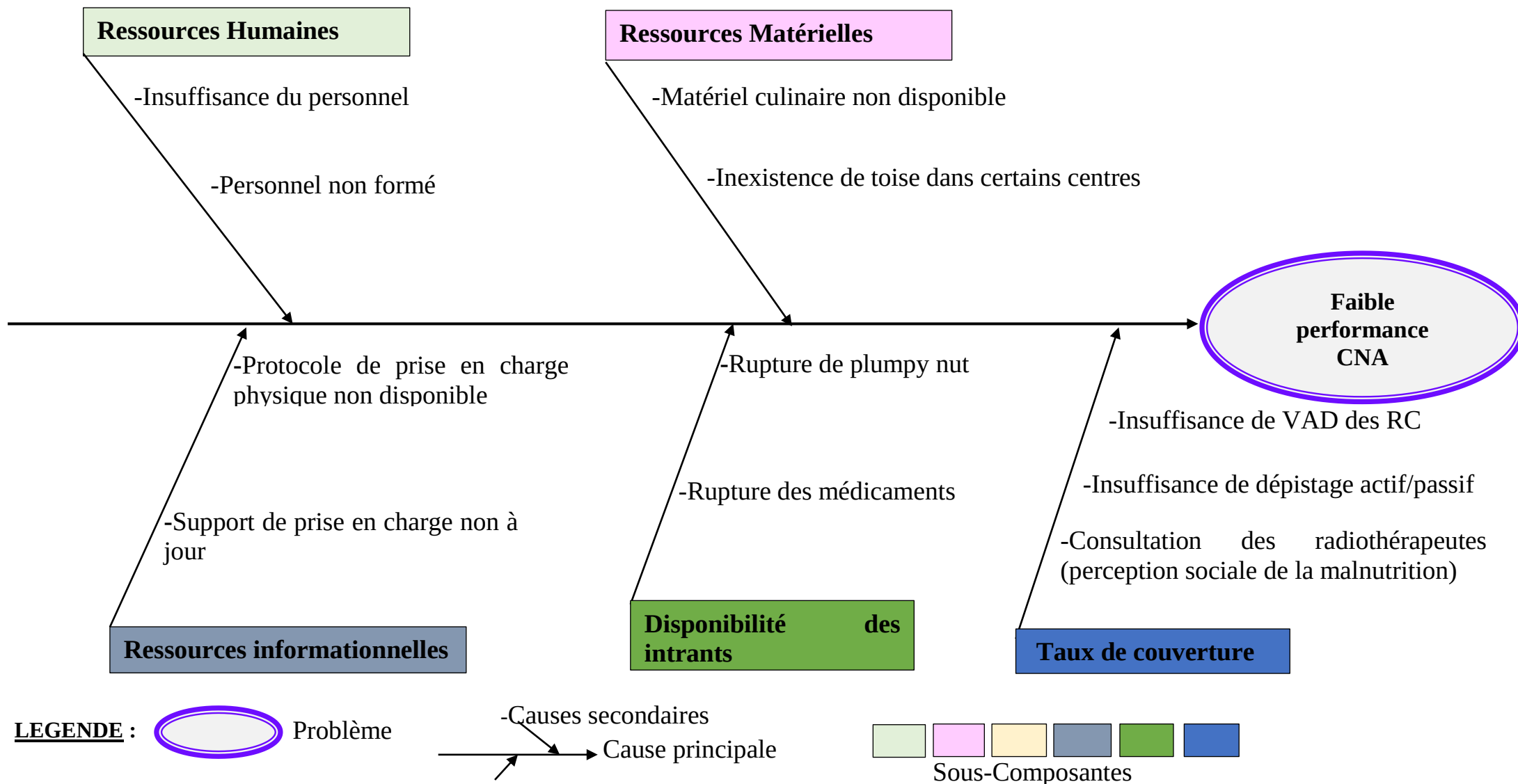


Figure 6 : Digramme d'Ishikawa des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNA de DCO

4.5.3 Diagramme d'ISHIKAWA des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNT

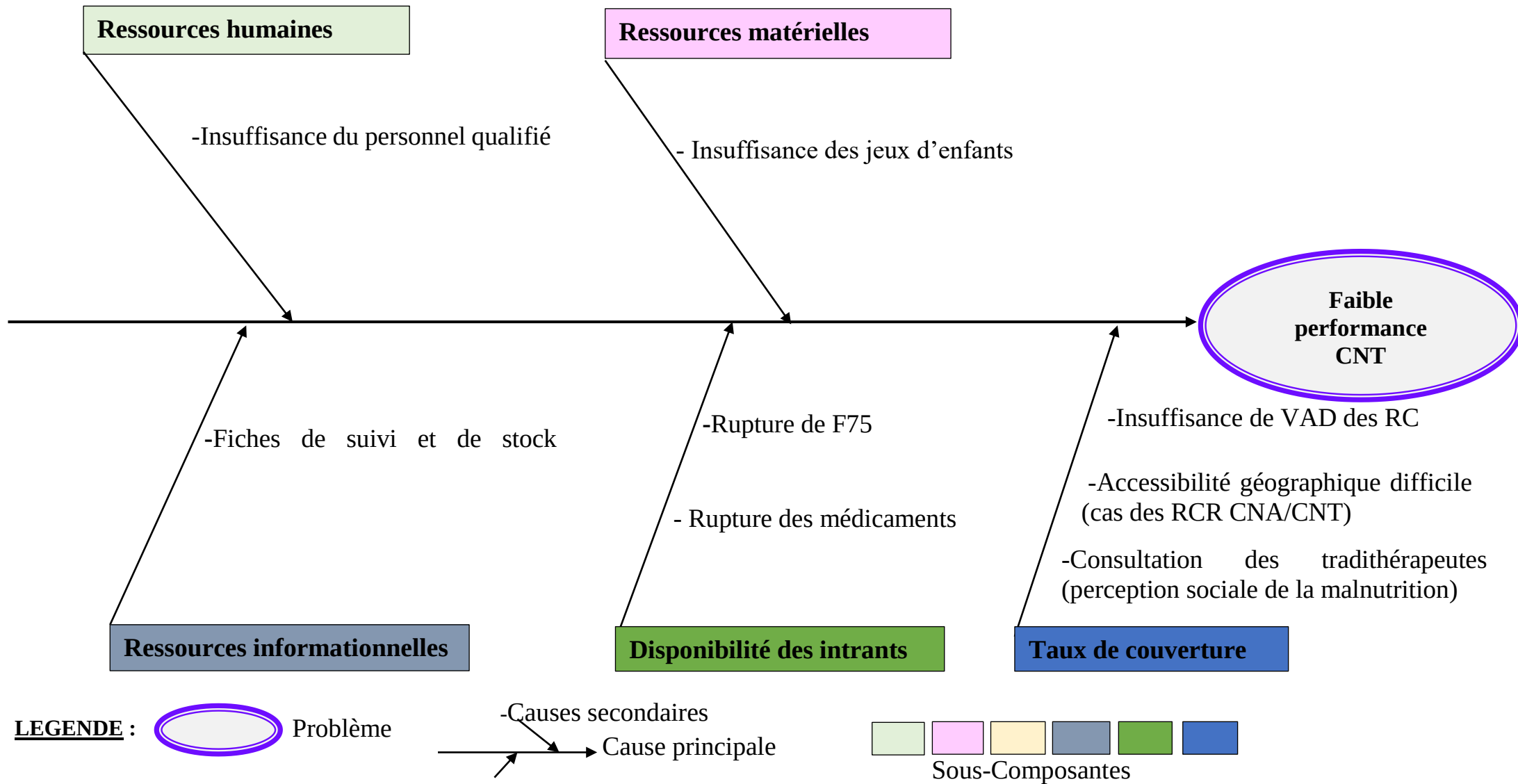


Figure 7 : Digramme d'Ishikawa des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNT de DCO

4.5.4 Analyse de l'impact de la faible performance des sous-composantes aux CNA/CNT de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2024

✍ Centres nutritionnels ambulatoires

L'insuffisance du personnel, la présence du personnel non formé, le manque de matériel culinaire, la rupture de plumpy nut et des médicaments, l'insuffisance de visites à domiciles par les relais communautaires, l'insuffisance de dépistage actif ou passif et la consultation des radiothérapeutes par la population du fait de la perception (en effet, selon certaines coutumes la malnutrition est considérée comme un mauvais sort) contribuent à une faible performance des centres nutritionnels.

✍ Centres nutritionnels thérapeutiques

L'insuffisance du personnel qualifié, le manque de jeu d'épanouissement, la rupture de F75 et de médicaments, l'accessibilité géographique difficile dans les cas de référence et l'insuffisance de fiche de suivi et de stock contribuent aussi sans doute à une faible performance de certaines sous-composantes de notre étude.

Ainsi, il s'avère nécessaire voire indispensable d'envisager des approches de solution

4.5.5 Stratégie de renforcement

Selon la matrice FFOM, l'intersection entre les facteurs internes à l'organisation (forces et faibles) et les facteurs externes (opportunités et menaces) ont permis de dégager quatre stratégies d'analyse pour le renforcement du système mis en place

- ✍ Stratégie d'attaque (forces + opportunités)
- ✍ Stratégie de défense (faiblesses + opportunité)
- ✍ Stratégie d'ajustement (forces + menaces)
- ✍ Stratégie de survie (faiblesses + menaces)

Pour rendre performant les CNA/CNT, nous avons opté pour la stratégie de défense. Les opportunités seront utilisées pour résoudre les faiblesses.

5. DISCUSSIONS

Notre discussion a abordé trois aspects en particulier :

- ✍ L'atteinte des objectifs
- ✍ Les limites de l'étude et la validation des données
- ✍ Les principaux résultats obtenus et leur comparaison avec les résultats issus d'autres auteurs.

5.1 Atteinte des objectifs

L'objectif général de cette étude était : « Evaluer la performance des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques dans la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2025 ».

A la fin de cette étude, nous avons :

- ✍ Parcouru tous les CNA/CNT (100%) fonctionnels en prise en charge de la malnutrition en 2024 ;
- ✍ Apprécié les structures de prise en charge de la malnutrition ;
- ✍ Décrit le processus de prise en charge ;
- ✍ Mesuré le niveau de performance des centres nutritionnels ;
- ✍ Comparé les résultats obtenus aux seuils du protocole national de prise en charge ;
- ✍ Proposé un plan de renforcement de la prise en charge dans cette zone sanitaire ;

Ainsi, nous sommes parvenus à montrer que :

- ✍ La performance au niveau CNA était globalement « Moyenne » (78,90%), avec pour détail, 70,32% pour la structure, 87,70% pour le processus et 87,50% pour résultats ;

- ✍ La performance au niveau CNT était globalement « Bonne » (83,33%), avec 75,00% pour la structure, 100% pour le processus et 87,50% pour résultats. A la lumière de tous ces résultats, nous pourrions estimer que nos objectifs sont atteints.

5.2 Limites de l'étude et la validité des résultats

Il s'avère nécessaire de noter que la présente étude pourrait présenter certaines limites probablement.

A ce propos, le nombre de CNT (02) objet d'une partie de notre étude était très restreint, et donc limite la représentativité des résultats.

L'une des limites principales de cette étude peut est due au fait que les résultats ne peuvent pas être généralisables à d'autres contextes. La raison étant que l'étude a été menée dans un seul contexte, zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké. Des caractéristiques spécifiques dudit contexte peuvent influencer les résultats, telles que la culture organisationnelle, les ressources disponibles, les procédures en place, les facteurs socio-culturels.

Cependant, toutes ces limites ne remettent pas en cause la validité de nos résultats.

5.3 Comparaison des résultats avec ceux d'autres auteurs

Les CNA ont enregistré une performance globale « Moyenne » tandis que celle des CNT est dite « Bonne ».

5.3.1 Structure de prise en charge

Dans cette étude, la disponibilité de la sous-composante ressources humaines était 42,63%. Dans une étude en 2014, sur l'évaluation de la performance de la prise en charge de la malnutrition aiguë ambulatoire chez les enfants de moins

de 5 ans dans le Nord du Bénin, Paraiso MN et al., ont trouvé que la disponibilité en ressources humaines était « bonne » [26]. Cette différence pourrait être expliquée par le fait de nouveaux infirmiers Majors n'ayant pas encore eu un renforcement de compétence. Ceci, à la suite des départs à la retraite ou départ pour des formations de spécialisation.

Dans notre étude, les résultats de la sous-composante disponibilité des ressources matérielles de prise en charge étaient 83,72% (CNA) et 92,86% (CNT). Ces résultats sont largement supérieurs à celui que Some Y et al., avaient trouvé en 2017 dans une étude sur l'évaluation de la gestion des intrants nutritionnels pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévères des enfants de 0 à 5 ans dans les centres de santé (CS) de la région du Centre au Burkina. En effet, ils ont trouvé que seulement 25% des CSPS/CM disposaient les équipements techniques nécessaires au stockage des intrants nutritionnels. Cette différence de résultat pourrait s'expliquer par le fait que les contextes d'étude n'étaient pas les mêmes. De plus, la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké bénéficie depuis 1987 à ce jour, de l'appui d'un projet (Projet Marigot) d'une coopération française qui fournit certains intrants et appui au dépistage actif. Dans la même étude, les auteurs ont aussi constaté un stock insuffisant avec les ruptures constatées de certains intrants traceurs comme le plumpy nut et l'amoxicilline au cours du premier trimestre de l'année 2017. Ces résultats sont semblables aux nôtres. Ils ont trouvé également que les outils de gestion de stock disponibles étaient irrégulièrement tenus à jour. Ce résultat est identique au nôtre. Cela pourrait s'expliquer par l'insuffisance du personnel ou du fait de leur surcharge de travail ou par manque de compétences [25].

5.3.2 Processus de prise en charge

Les résultats de la coordination étaient de 97,35% (CNA) et 100% (CNT) dans notre étude. Alors que dans une étude menée par Kenao TS et al., en 2016, au service de pédiatrie du Centre Hospitalier Départemental (CHD) Mono à Lokossa au Bénin, la supervision du personnel était faible (25%). Ce grand écart pourrait s'expliquer par la disponibilité des ressources humaines, matérielles, financière, temporelle et disponibilité des moyens de transport à la zone sanitaire DCO [26].

5.3.3 Résultats de prise en charge

Le taux de guérison était de 99,10% (CNA) dans notre étude. Contrairement, ce taux était de 8,94% dans une étude menée par Desyibelew FD et al., en 2017 sur le taux de guérison et les facteurs associés chez les enfants âgés de 6 à 59 mois admis pour malnutrition aiguë sévère dans l'unité d'hospitalisation de Bahir Dar Felege Hiwot, Hôpital du Nord-Ouest de l'Ethiopie. Leur cible était les enfant malnutris hospitalisés entre septembre 2012 à janvier 2016. La différence entre ces résultats, résulterait du fait que leur étude a pris en compte les malnutris sur une période de quatre. La durée pourrait occasionner des biais de perdus de vue, perte de dossiers ou autres supports d'information qui pourrait. Ces biais pourrait aussi influencer considérablement leur résultat [30].

Nous avons trouvé également dans notre étude un taux de létalité de 0% (CNA) et de 1,5% (CNT). Ce taux est largement inférieur à celui trouvé (7,7%) par Desyibelew FD et al dans ladite étude. Comparativement à la norme de PECMA (<10%), notre résultat était performant au leur [34].

Le taux de couverture était de 53,2%, inférieur à celui de PECMA (60%). L'écart pourrait s'expliquer du fait que près de 12% des centres de santé ne faisaient pas la prise en charge de la malnutrition en 2024.

CONCLUSION

Au terme de notre étude évaluative, l'analyse des résultats a ressorti une performance globale « Moyenne » pour les CNA tandis que celle des CNT est « Bonne ». Cette appréciation fait suite aux scores obtenus par les composantes explicatives (structures, processus et résultats) dont la résultante est la composante principale. Cette étude a dégagé non seulement les forces et les opportunités mais aussi les faiblesses et les menaces. Ainsi, pour améliorer la performance des centres dans la prise en charge MAS, il est indéniable de mettre en œuvre des actions ciblées et stratégiques. Le renforcement continue des compétences des ressources humaines et de nouvel recrutement de personnel qualifié est une nécessité. Il est aussi essentiel que les employés soient bien préparés et motivés dans l'exercice de leurs fonctions. Parlant de l'amélioration des processus d'approvisionnement, un plaidoyer doit être fait au partenaire privilégié UNICEF pour la dotation suffisante des intrants. Cela permettra une meilleure prise en charge.

Enfin, l'augmentation du nombre de séances de stratégie avancée et de dépistage passif systématique pourrait permettre une bonne couverture de la cible de la malnutrition. L'implication systématique des relais communautaires dans le dépistage actif et les références à temps des malnutris est indispensable.

La lutte contre la malnutrition, passe avant tout par la prévention et l'éducation nutritionnelle. Un accent particulier doit être mis sur l'éducation des parents surtout les mères. Ainsi, nous allons donc réduire la morbidité et la mortalité liées à la malnutrition.

6. SUGGESTIONS & RECOMMENDATIONS

Considérant les résultats auxquels nous sommes parvenus dans cette étude, nous formulons les suggestions suivantes à l'égard des différents acteurs en vue d'améliorer les performances des CNA/CNT dans la prise en charge de la malnutrition à la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2025.

 **A l'endroit du Médecin coordonnateur de zone sanitaire
Djougou-Copargo-Ouaké**

Faire le plaidoyer pour une dotation suffisante des intrants ;

Faire le plaidoyer auprès des partenaires pour la formation du personnel ;

Faire le plaidoyer pour la mutation d'un médecin pédiatre au CNT Ouaké.

 A l'endroit du Médecin chef du CNT de Ouaké

Equiper le centre nutritionnel thérapeutique de jeux d'enfants ;

Doter le centre nutritionnel ambulatoire de Kassoua d'un registre de prise charge.

 A l'endroit des prestataires de prise en charge

Mette à jour les supports de prise en charge.

 A l'endroit des partenaires d'appui

Planifier la formation du personnel ;

Augmenter la dotation des intrants.

 A l'endroit des relais communautaires

Accélérer le dépistage actif ;

Mettre en place un cahier de recherche des abandons.

 A l'endroit des mères d'enfants

Consulter à temps dès que l'enfant est malade.

Respecter les instructions diététiques reçues des prestataires.

6.1 Plan de renforcement de la performance de la prise en charge MAS

6.1.1 Contexte et justification

Malgré que la lutte contre la malnutrition date d'un passé lointain, elle reste un problème de santé publique, particulièrement en Afrique subsaharienne dont le Bénin fait partie. Selon les données de l'Enquête Démographique et de Santé EDS (MICS-Bénin), le retard de croissance a passé de 32 % à 36,60% de la période 2017-2018 à celle de 2021-2022.

A l'issue de notre étude focalisée sur l'Evaluation de la performance des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques de la ZS DCO, des insuffisances ont été relevées au niveau des composantes : structure, processus et résultats de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans cette zone sanitaire. Nous allons donc proposer un plan de renforcement pour minimiser ces insuffisances.

6.1.2 But

Le but de ce plan est de contribuer à l'amélioration de la performance des centres nutritionnels de prise en charge des enfants malnutris dans la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké.

6.2 Objectifs

6.2.1 Objectif général

Augmenter de 10% la performance des CNA/CNT dans la prise en charge de la malnutrition à la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké d'ici 2028.

6.2.2 Objectifs spécifiques

1. Renforcer le plateau technique de prise en charge de la malnutrition aiguë dans la ZS DCO d'ici 2028,
2. Sensibiliser la communauté sur le système de prise en charge d'ici 2025.
3. Assurer le suivi des activités nutritionnelles dans la zone sanitaire d'ici 2025.

6.3 Stratégies

Les stratégies principales à mettre en place se présente comme suit :

- ✍ Plaidoyer auprès des autorités et partenaires techniques et financiers pour améliorer le plateau technique des formations sanitaires
- ✍ Renforcement des capacités des agents de santé sur la prise en charge de la malnutrition aiguë
- ✍ Amélioration de la disponibilité des intrants dans la prise en charge de la malnutrition,
- ✍ Visite à domicile (VAD)
- ✍ Mobilisation sociale
- ✍ Communication pour le changement de comportement
- ✍ Coordination, surveillance et évaluation des activités de prise en charge.

6.4 Cadre de mise en œuvre

Le plan tactique sera mis en œuvre dans cette zone sanitaire par le Ministère de la Santé accompagné de l'UNICEF, les ONGs et les relais communautaires.

6.5 Coordination, surveillance et évaluation

Les différentes responsabilités de la mise en œuvre du plan tactique reviennent au médecin coordonnateur de la zone sanitaire, appuyer par son Equipe d'Encadrement (EEZ). Il rendra compte à un comité technique de pilotage composé comme suit :

- Directeur du département ;
- Représentant de la Direction de la Santé Mère et de l'Enfants (DSME) ;
- Représentant du Conseil national de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN) ;
- Représentant de la mairie chargée des activités de la santé ;
- Représentants des partenaires techniques et financiers (UNICEF, ONG...).

Le compte rendu sera fait par semestre par le comité technique en vue de donner des orientations et prendre des décisions nécessaires pour atteindre l'objectifs du programme. Au cours des réunions de ce comité, des plans d'action annuel seront rédigés et adoptés. Quant à la surveillance des activités, elle se fera sur la base des indicateurs prédéfinis. La surveillance permet de s'assurer que les activités entreprises se déroulent normalement ou rencontre des obstacles et pouvoir faire des ajustements si nécessaires. Au cours du projet une évaluation à mi-parcours sera faite par une équipe interne. A la fin du projet une autre équipe externe assurera l'évaluation de fin du projet en vue de la comparer aux objectifs de départ.

6.6 Chronogramme des activités du plan tactique de 3 ans

Tableau XXXI : Plan tactique pour l'amélioration de la performance des centres nutritionnels (CNA/CNT) dans la zone sanitaire Djougou- Copargo-Ouaké de 2026-2028

Stratégie	Activités	Ressources	Indicateurs	Responsables	Estimation du coût	Chronogramme		
						2026	2027	2028
Objectif spécifique 1 : Renforcer le plateau technique de prise en charge de la malnutrition aigüe dans la ZS- Djougou- Copargo-Ouaké d'ici 2028								
Plaidoyer auprès des autorités et partenaires techniques et financiers pour améliorer le plateau technique des formations sanitaires	Elaboration d'un plan de plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'équipement des CNA/CNT	Ressources humaines, Matérielles et financières	Disponibilité d'un document de plaidoyer	MCZS	100 000			
	Tenue des réunions ciblées auprès des autorités politico- administratives, des PTF, ONG, autorités sanitaires	Ressources humaines, Matérielles et financières	Proportion de réunions tenues sur attendues	MCZS	100 000			

Tableau XXXI : Plan tactique pour l'amélioration de la performance des centres nutritionnels (CNA/CNT) dans la zone sanitaire Djougou- Copargo-Ouaké de 2026-2028 (Suite)

Stratégie	Activités	Ressources	Indicateurs	Responsables	Estimation du coût	Chronogramme		
						2026	2027	2028
Objectif spécifique 1 : Renforcer le plateau technique de prise en charge de la malnutrition aigüe dans la ZS- Djougou- Copargo-Ouaké d’ici 2028								
Renforcement des capacités des agents de santé sur la prise en charge de la malnutrition aigüe	Elaborer un plan annuel de formation et recyclage des prestataires de service de malnutrition	Ressources humaines, Matérielles et financières	Existence d’un document de planification de formations/recyclages	MCZS	200 000			
	Exécution des formations et recyclages du personnel sur la prise en charge de la malnutrition	Ressources humaines, Matérielles et financières	Proportion des agents formés/recyclés en PECMA sur attendus	MCZS	9 030 000			
Renforcement de la disponibilité des intrants	Dotation en matériels de prise en charge	Ressources humaines, Matérielles et financières	Nombre et qualité de matériels dotés	MCZS	2 000 000			

Tableau XXXI : Plan tactique pour l'amélioration de la performance des centres nutritionnels (CNA/CNT) dans la zone sanitaire Djougou- Copargo-Ouaké de 2026-2028 **(Suite)**

Stratégie	Activités	Ressources	Indicateurs	Responsables	Estimation du coût	Chronogramme		
						2026	2027	2028
Objectif spécifique 2 : Sensibiliser la communauté sur le système de prise en charge d'ici 2028								
Mobilisation communautaire	Identification des leaders communautaires pour soutenir la recherche des cas	Ressources humaines, Matérielles et financières	Proportion des leaders désignés sur attendus	MCZS	430 000			
Communication pour le changement de comportement	Causerie éducative deux fois par semaine aux parents d'enfants	Ressources humaines, Matérielles et financières	Proportion des émissions radio réalisées sur attendues	MCZS Chargé de la communication	832 000			
	Organisation d'une émission radio par mois	Ressources humaines, Matérielles et financières	Proportions des causeries réalisées sur attendues	MCZS	2 000 000			

Tableau XXXI : Plan tactique pour l'amélioration de la performance des centres nutritionnels (CNA/CNT) dans la zone sanitaire Djougou- Copargo-Ouaké de 2026-2028 **(Suite et fin)**

Stratégie	Activités	Ressources	Indicateurs	Responsables	Estimation du coût	Chronogramme		
						2026	2027	2028
Objectif spécifique 3 : Assurer le suivi des activités nutritionnelles dans la zone sanitaire Djougou- Copargo-Ouaké d'ici 2028								
Coordination, supervision et évaluation des activités de prise en charge	Identification des points focaux nutrition	Ressources humaines, Matérielles et financières	Les points focaux nutrition sont connus	MCZS	20 000			
	Identification des acteurs de suivi/évaluation de la prise en charge MAS	Ressources humaines, Matérielles et financières	Les acteurs sont connus	MCZS	50 000			
	Organisation une fois par semestre des rencontres d'échanges sur le fonctionnement des CNA/CNT	Ressources humaines, Matérielles et financières	Les rencontres d'échanges réalisées	MCZS	175 000			
	Planification de suivi/évaluation	Ressources humaines, Matérielles et financières,	Plan de suivi/évaluation	MCZS	20 000			
	Evaluation de la performance des formations sanitaires nutritionnels	Ressources financières	Rapport d'évaluation	MCZS	1 540 000			

Tableau XXXII : Budget détaillé du pan tactique pour l'amélioration de la performance des CNA/CNT dans la prise en charge MAS de la ZS- Djougou- Copargo-Ouaké d'ici 2028

Objectifs	Activités	Nombre d'année	Coût par an (FCFA)	Coût total (FCFA)
Objectif spécifique 1 : Renforcer le plateau technique de prise en charge de la malnutrition aigüe dans la ZS- Djougou- Copargo-Ouaké d'ici 2028	Elaboration d'un plan de plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'équipement des CNA/CNT	1	100 000	100 000
	Tenue des réunions ciblées auprès des autorités politico-administratives, des PTF, ONG, autorités sanitaires	3	100 000	300 000
	Elaborer un plan annuel de formation et recyclage des prestataires de service de malnutrition	3	200 000	600 000
	Exécution des formations et recyclages du personnel sur la prise en charge MAS	2	9 030 000	18 060 000
	Dotation en matériels de prise en charge	3	2 000 000	6 000 000
Sous-total 1				25 060 000

Tableau XXXII : Budget détaillé du pan tactique pour l'amélioration de la performance des CNA/CNT dans la prise en charge MAS de la ZS- Djougou- Copargo-Ouaké d'ici 2028 (Suite et fin)

Objectifs	Activités	Nombre d'année	Coût par an (FCFA)	Coût total (FCFA)
Objectif spécifique 2 : Sensibiliser la communauté sur le système de prise en charge d'ici 2028	Identification des leaders communautaires pour soutenir la recherche des cas	1	430 000	430 000
	Causerie éducative deux fois par semaine aux mères d'enfants	3	832 000	2 496 000
	Organisation d'une émission radio par semaine	3	2 000 000	6 000 000
Sous-total 2				8 926 000
Objectif spécifique 3 : Assurer le suivi des activités nutritionnelles dans la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké d'ici 2028	Identification des points focaux nutrition	1	20 000	20 000
	Identification des acteurs de suivi/évaluation de la prise en charge MAS	1	50 000	50 000
	Organisation une fois par semestre des rencontres d'échanges sur le fonctionnement des CNA/CNT	3	175 000	525 000
	Planification de suivi/évaluation	1	20 000	20 000
	Evaluation de la performance des formations sanitaires nutritionnels	1	1 540 000	1 540 000
Sous-total 3				2 155 000
Totaux (1+ 2 +3)			36 141 000	

Arrêté le présent plan tactique à la somme de : Trente-six millions cent quarante et un mille francs CFA (36 141 000 FCFA)

REFERENCES

1. Black RE, et al. Dénutrition et surpoids maternels et infantiles dans les pays à faible revenu et intermédiaires. Lancet. 2013 Aug 3;382(9890):427-51.
2. Organisation mondiale de la Santé. Normes de croissance de l'enfant [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: <https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/child-growth-standards>
3. Bhutta ZA, Ahmed T, Black RE, Cousens S, Kirkwood B, Sachdev HPS, et al. Qu'est-ce qui fonctionne ? Interventions pour la santé maternelle, infantile, la dénutrition et la survie de l'enfant. Lancet. 2008 Aug 2;371(9610):417-40.
4. Organisation des Nations-Unies pour l'enfance. La situation des enfants dans le monde 2024 [Internet]. 2024 [cité 2025 juin 25]. Disponible sur: <https://www.unicef.lu/site-root/wp-content/uploads/2024/11/UNICEF-La-situation-des-enfants-dans-le-monde-2024.pdf>
5. Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/DGM-3_volets_web_cle431a73.pdf
6. Ministère du Plan et du Développement. Institut National de la Statistique et de la Démographie [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: <https://instad.bj/statistiques/statistiques-demographiques>
7. Sawadogo S. Malnutrition chronique et facteurs associés chez des enfants de moins de cinq ans du district sanitaire de Tenkodogo (Burkina Faso). 2013;1-59. [Mémoire, thèse d'université].
8. Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, Caulfield LE, de Onis M, Ezzati M, et al. Dénutrition maternelle et infantile: expositions mondiales et régionales et conséquences sur la santé. Lancet. 2008 Jan 26;371(9608):243-60.
9. Mongbo V, Ouendo EM, Idé GN, Sossa-Jerôme C, Makoutodé P, Saïzonou J et al. Facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans

- de Za-Kpota, Bénin, 2018. Rev Marocaine Santé Publique [Internet]. 2018 [cité 2025 févr 25];9(14). Disponible sur: <https://revues.imist.ma/index.php/RMSP/article/view/26155>
10. Organisation mondiale de la Santé. Lignes directrices pour la prévention et la prise en charge de l'émaciation et des problèmes nutritionnels chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans [Internet]. 2020 [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240082830>
 11. Diabaté I. Enquête nationale nutritionnelle anthropométrique et de mortalité rétrospective. 2013;1-120. [Rapport].
 12. Diawara F, Diarra N, Telly N, Berthé M, Coulibaly D, Ag Iknane A. Marasme et kwashiorkor chez les 6-59 mois: infections courantes à l'URENI, Bamako [Internet]. [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/353111115_Marasme_et_kwas_hiorkor_chez_les_6-59_mois_Infections_courantes_a_l'URENI_Bamako
 13. Black RE, Victora CG, Walker SP, Bhutta ZA, Christian P, de Onis M, et al. Dénutrition et surpoids maternels et infantiles dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Lancet. 2013 Aug 3;382(9890):427-51.
 14. Tokponou J. Politique nationale d'alimentation et de nutrition 2024-2033: La Nation Bénin; 2024 [cité 2025 juin 25]. Disponible sur: <https://lanation.bj/actualites/politique-nationale-dalimentation-et-de-nutrition-2024-2033-un-document-de-reference-pour-reduire-la-malnutrition>
 15. Organisation mondiale de la Santé. Atlas des statistiques sanitaires africaines 2022: analyse de la situation sanitaire de la Région africaine - Rapport de synthèse [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: <https://www.afro.who.int/fr/publications/atlas-des-statistiques-sanitaires-africaines-2022-analyse-de-la-situation-sanitaire-de>

16. Donabedian A. Cadre de référence et hypothèses [Internet]. [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: <https://123dok.net/article/mod%C3%A8le-donabedian-cadre-r%C3%A9f%C3%A9rence-hypoth%C3%A8ses.wq2m6ey1>
17. Ouro-Koura AR, Sopoh EG, Sossa JC, Glèlè-Ahanhanzo Y, Agueh V, Ouendo EM, et al. Evaluation de la performance du système de gestion logistique des intrants de lutte contre le paludisme dans le Département du Littoral, au Bénin, en 2017. Pan Afr Med J [Internet]. 2018 [cité 2025 mai 19];29(61). Disponible sur: <https://www.panafrican-med-journal.com//content/article/29/61/full>
18. Bureau de l'évaluation des politiques publique Bénin. Guide Méthodologique National d'évaluation [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 19]. Disponible sur: <https://evaluation.gouv.bj/uploads/GuideMethodologique.pdf>
19. Diawara F. Marasme et kwashiorkor chez les 6-59 mois: infections courantes à l'URENI, Bamako. ResearchGate [Internet]. 2019 [cité 2025 juin 25];27-32. Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/353111115_Marasme_et_kwas_hiorkor_chez_les_6-59_mois_Infections_courantes_a_l'URENI_Bamako
20. Diawara F. Marasme et kwashiorkor: les différents types de malnutrition chez les enfants [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: <https://www.espace-sante-conseil.com/marasme-et-kwashiorkor-les-differents-types-de-malnutrition/>
21. Organisation des Nations Unies pour l'Enfance. Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi | UNICEF Canada [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 18]. Disponible sur: <https://www.unicef.ca/fr/decouvrez/a-l-echelle-mondiale/malnutrition/aliments-therapeutiques-prets-a-l-emploi>
22. Guesdon B. et Roberfroid D. Des critères de sortie sous-standards dans les protocoles actuels de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère: une source

jusqu'alors impensée d'inefficacité pour les programmes? | ENN [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 18]. Disponible

sur: <https://www.ennonline.net/fex/60/fr/des-criteres-de-sortie-sous-standards-dans-les-protocoles-actuels-de-prise-en-charge-de>

23. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'approche communautaire de la protection [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 19]. Disponible sur: <https://emergency.unhcr.org/fr/protection/m%C3%A9canismes-de-protection/l%E2%80%99approche-communautaire-de-la-protection>

24. Maleta K, Amadi B. Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA) en Afrique du sud-sahara: études sur les causes au Ghana, Malawi et Zambia. Food Nutr Bull. 2014 Jun;35(2 Suppl):S34-8.

25. Dembele J. Evaluation de la prise en charge de la malnutrition aiguë au CREN du CSPS [Internet]. 2019 Dec 31 [cité 2025 mai 19];14-7. Mémoire Online. Disponible sur: <https://www.memoireonline.com/09/13/7428/Evaluation-de-la-prise-en-charge-de-la-malnutrition-aigu-au-CREN--Centre-de-Recuperation-et-d.html>

26. Paraïso MN, Agueh V, Jerome CS, Azandjeme C, Agbehonou KP, Ade VM, et al. Évaluation de la performance de la prise en charge ambulatoire de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans dans le cadre nord du Bénin. Int J Trop Dis Health [Internet]. 2016 Oct 14 [cité 2025 mai 20];1-11. Disponible sur: <https://journalijtdh.com/index.php/IJTDH/article/view/243>

27. Kénao S. Et al., Evaluation de la qualité de la prise en charge hospitalière des maladies aiguës sévères [Internet]. ResearchGate. 2017 Nov 15 [cité 2025 mai 19];8(11):1012-21. Disponible sur: <https://www.researchgate.net/profile/Tchasso-Kenao>

28. Jayatissa R, Bekele A, Kethiswaran A, Silva A. Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère et modérée lors des situations

d'urgence au Sri Lanka. Food Nutr Bull [Internet]. 2012 [cité 2025 mai 19];33(4):251. Disponible

sur: https://www.academia.edu/110072525/Community_Based_Management_of_Severe_and_Moderate_Acute_Malnutrition_during_Emergencies_in_Sri_Lanka_Challenges_of_Implementation

29. Ouattara CA, Tinto R, Traore IT, Traore S, Tamboura H, Bamouni J, et al. Facteurs pronostiques de la mortalité néonatale au CHU Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso: une étude transversale. Pan Afr Med J [Internet]. 2024 Apr 2 [cité 2025 mai 19];47(154). Disponible sur: <https://www.panafrican-med-journal.com//content/article/47/154/full>
30. Desyibelew HD, Fekadu A, Woldie H. Taux de guérison et facteurs associés chez les enfants âgés de 6 à 59 mois admis pour malnutrition aiguë sévère à l'unité d'hospitalisation de Bahir Dar Felege Hiwot Hôpital de référence, unité d'alimentation thérapeutique, nord-ouest de l'Éthiopie. PLoS One. 2017 Feb 9;12(2):e0171020.
31. Données Carte Sanitaire DCO, édition 3 [Internet]. Bing. [cité 2025 mai 23]. Disponible sur: <https://www.bing.com/images/search?q=donnee+carte+statistique+dco+édition3&qpvt=donnee+carte+statistique+dco%2c+édition3&form=igre>
32. Commune de Djougou. Plan de Développement Communal 2023-2027 Quatrième Génération (PDC4) (2023) [Internet]. 2023 [cité 2025 mai 23]. Disponible sur: <https://www.credd-benin.com/references/elaboration-du-plan-de-developpement-communal-2023-2027-quatrieme-generation-pdc4/>
33. Agboton B L, Agueh V D, Bodjrenou A S, Vigan J, Ahoui S, Agboton C G et al. État des lieux et évaluation de la qualité de la thérapie nutritionnelle des patients porteurs de syndrome métabolique au CNHU-HKM de Cotonou [Internet]. 2025 [cité 2025 mai 20]. Disponible

sur: <https://bec.uac.bj/uploads/publication/a917ab738c7db0ba75381fd3d7a91baf.pdf>

34. Ashworth A, Khanum S, Jackson A, Schofield EC. Directives pour le traitement hospitalier des enfants sévèrement malnutris [Internet]. 2005 [cité 2025 mai 20]. Disponible sur: <https://iris.who.int/handle/10665/43071>

ANNEXES

Annexe 1 : Images



Figure 3 : Image de la séance du briefing des enquêteurs



Source : photo prise au CNT Ordre de Malte de Djougou, avril 2025

Figure 4 : Matériel de jeux des malnutris



Figure 5 : Image de la note d'autorisation de collecte des données

OUTILS DE COLLECTE EVALUATION CNA/CNT

Annexe 2 : Outils de collecte des données

Evaluation de la performance des CNA/CNT de la ZS DCO en 2025

FICHE DE DEPOUILLEMENT SUPPORTS DE COLLECTE

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Arrondissement/Village/quartier :

Nom du Centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur

Processus

Critères d'admission au CNA respectés P/T<-3ET ou PB <11,5 cm ; appétit bon : Nombre d'enfant admis avec respect de critères /_____/

Q14. Nombre de fiche de suivi correctement remplis jusqu' à la sortie (date de sortie, la cause de sortie et les données anthropométriques) /_____/

Q17 Utilisation correcte de fiche de références-contre référence

Nombre de référence faites /_____/

Nombre de fiche de référence remplis /_____/

Q18 Rapport mensuel élaboré (1=oui 0 = non) /_____/

Q19 traitement diététique chez tous les enfants (utilisation d'ATPE /_____/

Q20 -Traitement systématiquement des malnutris avec de :

Amoxicillines à l'admission /_____/

Acide folique à l'admission /_____/

Vitamine A la 4èvisite /_____/

Antipaludiques à l'admission /_____/

Déparasitant à la 2eme visite /____/

Vaccination contre la rougeole pour les enfants de plus de 9 mois non
vaccinés, à la 4^{ème} visite /____/

Annexe 3

GRILLE D'OBSERVATION DES AGENTS DE SANTE

Numéro de la fiche /-----/

Date de l'enquête -----/-----/-----

Village :

Nom du centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

I. Structure du CNA

Oui = 1 non= 0

Q13 Dépistage systématique à chaque consultation

Prise de la taille

Disposition correcte de la toise /_____/

Déchaussement de l'enfant /_____/

Placement de l'enfant fixe, nuque, dos, fesse, mollet, talons contre la planchette /_____/

Maintien du bras le long du corps les paumes face à la couture du pantalon /_____/

Opérateur se fait assister par une aide /_____/

Opérateur se place du côté de l'aide /_____/

Maintien du regard perpendiculaire à la toise /_____/

Score taille /_____/ / 14

Prise du poids

Balance placée sur une surface plane /_____/

Déshabillage et déchaussement de l'enfant /_____/

Placement de l'enfant entièrement sur la balance /_____/

Lecture du poids et notation /_____/

Score poids /_____/ / 8

Utilisation de la table poids/taille /_____/

Score total

/ ____ / /24

Annexe 3

Grille d'observation Matériel

Numéro de la fiche /-----/

Date de l'enquête -----/-----/-----

Village :

Nom du centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

I. Structure

1 = oui 0 = non

. Matériel d'éducation nutritionnelle (boîte à images de la malnutrition)

/ ____ /

Matériel de démonstration culinaire / ____ /

Stock d'ATPE : nombre de jours de rupture / ____ /

Stock de médicaments de traitement systématique (nombre de jour de rupture)

Amoxicilline / ____ /

Acide folique / ____ /

Déparasitant / ____ /

Vitamine A / ____ /

Antipaludique / ____ /

Matériel anthropométrique : (1= oui 0 = non)

Toise pour enfant de moins de 2 ans : / ____ /

Toise pour enfant de plus de 2 ans / ____ /

Pèse-personne : / ____ /

Balance Salter / ____ /

Brassard pour la mesure du PB : / ____ /

Table poids/taille : / ____ /

Thermomètre : / ____ /

Existence de protocole de prise en charge : /_____/

Annexe 4

GUIDE D'ENTRETIEN : MEDECINS DE COMMUNE/ POINT FOCAL ZONE SANITAIRE

Numéro de la fiche /-----/

Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Nom et prénom de l'enquêteur :

1.Approvisionnement des centres nutritionnels ambulatoires en ATPE et médicaments

.....
.....
.....
.....

2. ONG intervenant dans la prise en charge de la malnutrition aigue

.....
.....
.....
.....

3.Mobilisation communautaire

.....
.....
.....

4. Organisation des supervisions des activités de prise en charge de la malnutrition

.....
.....
.....
.....

Suggestion pour l'amélioration de la prise en charge de la malnutrition

.....
.....
.....
.....

Merci

Annexe 5

QUESTIONNAIRE AUX AGENTS DE SANTE

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Arrondissement/Village/quartier :

Nom du Centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

. Identité de l'enquêté

Q1. Qualification : (cocher la réponse) IDE /...../ IB /_____/ SF /_____/ AS /_____/

Q2 (Age année) : /...../

Q3 Sexe : M F (entourer la réponse)

Q4 Ancienneté au poste actuel (année) :

II. Processus de prise en charge

Q5-Proportion de la population à moins de 5km du centre de santé (%)

- Connaissance sur la malnutrition aiguë

Q6 Comment définissez-vous la malnutrition aiguë ? (Réponse citée = 2, absence de réponse =0)

PB < 11,5cm /_____/ ou P/T < -2ET /_____/

Q7 Citez les éléments du diagnostic de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans

Œdèmes bilatéraux /_____/

Fonte musculaire /_____/

Cheveux normaux, /décolorés, cassants, secs et clairsemés /_____/

Total reconnaissance : /_____/ /8

Q8 Quelles sont les causes de la malnutrition

Sevrage précoce /_____/

Alimentation inadéquate (pauvre en nutriment) /_____/

Malabsorption /_____/

Maladies (infections/parasitoses) /_____/

Total causes /_____/ / 8

Q9 Quels sont les éléments du suivi d'un enfant souffrant de la malnutrition aiguë ? (Réponse citée = 2, absence de réponse =0

-Test de l'appétit une fois par semaine /_____/

-Pesée et appréciation du poids une fois par semaine /_____/

-Mesure du PB chaque semaine /_____/

-Recherche de la présence d'œdèmes chaque semaine /_____/

-Prise de la température corporelle chaque semaine /_____/

-Recherche des symptômes et signes cliniques chaque semaine /_____/

-Education nutritionnelle chaque semaine /_____/

-Calcul du gain de poids à la sortie /_____/

-Visites à domicile /_____/

-Mesure de la taille chaque mois /_____/

Total suivi /_____/ / 20

Q10 Faites-vous le dépistage des malnutris en stratégie avancée (Cocher)

Oui /_____/ non /_____/

Difficultés

Q11 Avez-vous des difficultés dans la prise en charge des malnutris ?

Oui /_____/ non /_____/

Si oui lesquelles ?

Rupture de stock ATPE /_____/

Rupture de médicaments /_____/

Péremption /_____/

Autres /_____/ préciser

Supervision

Q12 combien de fois avez-vous été supervisé en 2013 dans le cadre de la malnutrition aiguë ? /_____/ (voir cahier de supervision)

Q12 A Réaliser-vous des séances d'éducation nutritionnelle à l'endroit des mères des malnutris ? Oui /_____/ non /_____/

Q12 B Faites-vous des démonstrations culinaires ? Oui /_____/ non /_____/

Annexe 6

GRILLE D'OBSERVATION AGENT DE SANTE

Numéro de la fiche /-----/

Date de l'enquête -----/-----/-----

Nom du centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

I. Structure du CNA/CNT

Oui = 1 non=

Q13 Dépistage systématique à chaque consultation

Prise de la taille

Disposition correcte de la toise /_____/

Déchaussement de l'enfant /_____/

Placement de l'enfant fixe, nuque, dos, fesse, mollet,

Talons contre la planchette /_____/

Maintien du bras le long du corps les paumes face à

la couture du pantalon /_____/

Opérateur se fait assister par une aide /_____/

Opérateur se place du côté de l'aide /_____/

Maintien du regard perpendiculaire à la toise /_____/

Score taille /_____/ / 14

Prise du poids

Balance placée sur une surface plane /_____/

Déshabillage et déchaussement de l'enfant /_____/

Placement de l'enfant entièrement sur la balance /_____/

Lecture du poids et notation /_____/

Score poids /_____/ / 8

Utilisation de la table poids/taille /_____/

Score total /_____/ /24

Annexe 7

FICHE DE DEPOUILLEMENT DE SUPPORTS DE GESTION

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Arrondissement/Village/quartier :

Nom du Centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur

Processus

Critères d'admission au CNA/CNT respectés $P/T < -3ET$ ou $PB < 11,5$ cm ;
appétit bon : Nombre d'enfant admis avec respect de critères /____/

Q14. Nombre de fiche de suivi correctement remplis jusqu' à la sortie (date de sortie, la cause de sortie et les données anthropométriques)

/____/

Q17 Utilisation correcte de fiche de références-contre référence

Nombre de référence faites /____/

Nombre de fiche de référence remplis /____/

Q18 Rapport mensuel élaboré (1=oui 0 = non) /____/

Q19 traitement diététique chez tous les enfants (utilisation d'ATPE)

/____/

Q20 SI CNT continuer avec :

F75/-----/

F100/...../

Q21-Traitement systématiquement des malnutris avec de :

Amoxicilline à l'admission	/____/
Acide folique à l'admission	/____/
Vitamine A la 4 ^e visite	/____/
Antipaludiques à l'admission	/____/
Déparasitant à la 2eme visite	/____/
Vaccination contre la rougeole pour les enfants de plus de 9 mois non vaccinés, à la 4 ^{ème} visite	/____/

Annexe 8

QUESTIONNAIRE AUX RELAIS COMMUNAUTAIRES

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Arrondissement/Village/quartier :

Nom du Centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

Identité de l'enquêté

Q21 Age (années) :

Q22 Sexe : M /_____/ F/_____/

Q23 Niveau d'instruction Aucun = 1 primaire =2 Secondaire =3 (encerclé)

Q24 Faites-vous le dépistage de la malnutrition dans la communauté ?

Oui /_____/ non /_____/

Q25 comment reconnaissez-vous la malnutrition aiguë ?

-PB <11,5 cm ou brassard dans le jaune /_____/

Q26 Que faites-vous après avoir dépisté un malnutri

Référence /_____/ conseils /_____/

Q27 Faites-vous le suivi des malnutris sous traitement ?

Oui /_____/ non /_____/

Q28. Recherchez-vous les perdus de vue ? Oui /_____/ non /_____/

Q29. Combien de fois avez-vous été supervisés en 2013 ?

Q30 avez-vous une motivation dans le cadre de la PCMA

Oui /_____/ non /_____/

Q31 Existe –t-il une ONG qui intervient dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition aiguë ? Oui /_____/ non /_____/

Annexe 8

FICHE DE DEPOUILLEMENT

(Pour la période allant du 1^{er} Janvier au 31 décembre 2024)

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune : Arrondissement/Village :

Nom de Centre Nutritionnel : _____ Nom et prénom de l'enquêteur _____

[illegible]

Annexe 9

Evaluation de la performance de la prise en charge de la malnutrition aiguë dans les CNA/CNT de la ZS DCO en 2025

QUESTIONNAIRE AUX AGENTS DE SANTE

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Arrondissement/Village/quartier :

Nom du Centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

I. Identité de l'enquêté

Q1. Qualification : (cocher la réponse) IDE /...../ IB /_____/SF/_____/ AS /_____/

Q2 (Age année) : /...../

Q3 Sexe : M F (entourer la réponse)

Q4 Ancienneté au poste actuel (année):.....

II. Processus de prise en charge

Q5-Proportion de la population à moins de 5km du centre de santé(%)

- Connaissance sur la malnutrition aiguë

Q6 Comment définissez-vous la malnutrition aiguë ? (réponse citée = 2, absence de réponse =0)

PB < 11,5cm /_____/ ou P/T < -2ET /_____/

Q7 Citez les éléments du diagnostic de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans

Œdèmes bilatéraux /_____/

Fonte musculaire /_____/

Cheveux normaux,/décolorés, cassants, secs et clairsemés /_____/

Total reconnaissance : /_____/ /8

Q8 Quelles sont les causes de la malnutrition

Sevrage précoce /_____/

Alimentation inadéquate (pauvre en nutriment) /_____/

Malabsorption /_____/

Maladies (infections/parasitoses) /_____/

Total causes /_____/ / 8

Q9 Quels sont les éléments du suivi d'un enfant souffrant de la malnutrition aiguë ? (réponse citée = 2, absence de réponse =0

-Test de l'appétit une fois par semaine /_____/

-Pesée et appréciation du poids une fois par semaine /_____/

-Mesure du PB chaque semaine /_____/

-Recherche de la présence d'œdèmes chaque semaine /_____/

-Prise de la température corporelle chaque semaine /_____/

-Recherche des symptômes et signes cliniques chaque semaine /_____/

-Education nutritionnelle chaque semaine /_____/

-Calcul du gain de poids à la sortie /_____/

-Visites à domicile /_____/

-Mesure de la taille chaque mois /_____/

Total suivi /_____/ / 20

Q10 Faites-vous le dépistage des malnutris en stratégie avancée (Cocher)

oui /_____/ non /_____/

Difficultés

Q11 Avez-vous des difficultés dans la prise en charge des malnutris ?

oui /_____/ non /_____/

Si oui lesquelles ?

Rupture de stock ATPE /_____/

Rupture de médicaments /_____/

Péremption /_____/

Manque de place /_____/

Autres /_____/ préciser

Supervision

Q12 combien de fois avez-vous été supervisé en 2013 dans le cadre de la malnutrition aiguë? /_____/ (voir cahier de supervision)

Q12 A Réaliser-vous des séances d'éducation nutritionnelle à l'endroit des mères des malnutris ? oui /_____/ non /_____/

Q12 B Faites-vous des démonstrations culinaires ?

oui /_____/ non /_____/

Si non pourquoi ?

Annexe 10

Evaluation de la performance de la prise en charge de la malnutrition aigüe dans les CNA/CNT de la ZS DCO en 2025

QUESTIONNAIRE AUX RELAIS COMMUNAUTAIRES

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Arrondissement/Village/quartier :

Nom du Centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

Identité de l'enquête

Q21 Age (années) :

Q22 Sexe : M /_____/ F/_____/

Q23 Niveau d'instruction Aucun = 1 primaire =2 Secondaire =3 (encerclé)

Q24 Faites-vous le dépistage de la malnutrition dans la communauté ?

oui /_____/ non /_____/

Q25 comment reconnaissez-vous la malnutrition aiguë ?

-PB <11,5 cm ou brassard dans le jaune /_____/

Q26 Que faites-vous après avoir dépisté un malnutri

Référence /_____/ conseils /_____/

Q27 Faites-vous le suivi des malnutris sous traitement ?

oui /_____/ non /_____/

Q28. Recherchez-vous les perdus de vue ? oui /_____/ non /_____/

Q29 . Combien de fois avez-vous été supervisés en 2025?

Q30 avez-vous une motivation dans le cadre de la PeCMA

oui /_____/ non /_____/

Q31 Existe –t-il une ONG qui intervient dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition aigüe ? oui /_____/ non /_____/

Annexe 11

Evaluation de la performance de la prise en charge de la malnutrition aigüe dans les CNT de la ZS DCO en 2025

QUESTIONNAIRE AU RESPONSABLES DE CNT

Numéro de la fiche /-----/ Date de l'enquête -----/-----/-----

Commune :

Arrondissement/Village/quartier :

Nom du Centre de Santé :

Nom et prénom de l'enquêteur :

Identité de l'enquêté

Q32 Age (années) :

Q33 Sexe : M /_____/ F/_____/

Q34 Niveau d'instruction Aucun = 1 primaire =2 Secondaire =3 (encerclé)

Q35 Existe-il un Médecin Pédiatre dans le service ?

oui /_____/ non /_____/

Q36 Existe-il un (e) nutritionniste dans le service ?

Q37 La sérologie au VIH est-il systématique chez les malnutris oui

/_____/ non /_____/

Q38 Les visites médicales sont-elles réalisées au moins une fois/jour ?

oui /_____/ non /_____/

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES

ACTION DE GRACE	ii
DEDICACE.....	iii
IN MEMORY	v
REMERCIEMENTS.....	vi
HOMMAGES	viii
LISTE DES ABREVIATIONS, ACRONYMES et SIGLES	ix
ABSTRACT	xi
LISTE DES TABLEAUX	xii
LISTE DES FIGURES.....	xv
1.1 Enoncé du problème	5
1.2 Cadre conceptuel	7
1.	9
1.1	9
1.2	9
1.3 Schéma du cadre conceptuel.....	9
1.3.1 Explication du cadre conceptuel	9
1.4 Hypothèse	11
1.5 Objectifs.....	12
1.5.1 Objectif général	12
1.5.2 Objectifs spécifiques	12
2.1 Définition opératoire des concepts et termes essentiels	14

2.2	Quelques informations sur la malnutrition.....	17
2.2.1	Historique de la prise en charge de la malnutrition aiguë.....	17
2.2.2	Informations sur le fonctionnement des centres nutritionnels ambulatoires et thérapeutiques	18
2.2.3	Indicateurs de performance des centres de prise en charge de la malnutrition	19
2.3	Revue de littérature	20
2.3.1	Composante « Structure »	20
2.3.2	Composante « Processus »	21
2.3.3	Composante « Résultats ».....	21
3.1	Cadre d'étude.....	24
3.1.1	Situation géographique.....	24
3.1.2	Caractéristiques démographiques.....	26
3.1.3	Aspects socio-culturels et économiques	26
3.1.4	Aspects administratifs	26
3.1.5	Données sanitaires.....	27
3.1.6	Consultations curatives	27
3.2	Type et période d'étude.....	27
3.3	Population d'étude.....	27
3.3.1	Populations cible	27
3.4	Critères de sélection.....	28
3.5	Méthode et techniques d'échantillonnage	28
3.5.1	Méthode d'échantillonnage	28

3.5.2	Techniques d'échantillonnage.....	28
3.5.3	Taille de l'échantillon.....	29
3.6	Les variables d'étude.....	29
3.7	Aspects opérationnels des variables.....	30
3.7.1	Aspects opérationnels des variables des CNA.....	31
3.7.2	Aspects opérationnels des variables dans les CNT.....	44
3.8	. Techniques et outils de collecte.....	53
3.9	Période de collecte.....	53
3.10	Plan de traitement et d'analyse des données.....	54
3.10.1	Traitement des données.....	54
3.10.2	Analyse des données	54
3.10.3	Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM).....	54
3.10.4	Diagramme d'Hishikawa des causes probables des faiblesses	54
3.11	Aspects éthiques et déontologiques	55
3.12	Style de référence.....	55
4.1	Description des composantes « structure », « processus » et « résultats »	57
4.1.1	Description des éléments de la « structure ».....	57
4.1.2	Synthèse des résultats de la composante « Structure » des CNA/CNT en 2025.....	62
4.1.3	Description des éléments du « Processus ».....	62
4.2	Présentation des résultats par centre de prise en charge de la malnutrition	68

4.2.1	Présentation des « résultats » de la prise en charge de la malnutrition par commune dans les CNA en 2025	68
4.2.2	Présentation des résultats de la prise en charge de la malnutrition par commune dans les CNT en 2025	72
4.2.3	Présentation des résultats de la composante « résultats » en fonction de ses éléments constitutifs aux CNA/CNT en 2025.....	73
4.3	Appréciation globale de la composante principale à partir des composantes « structure », « processus » et « résultats ».....	74
4.3.1	Tableau XXVIII : Appréciation globale de la composante principale	74
4.4	Comparaison des résultats avec les normes du protocole national de prise en charge	75
4.5	Analyse stratégique.....	76
4.5.1	Analyse des forces, faiblesse, opportunité, menaces (FFOM).....	76
4.5.2	Digramme d'ISHIKAWA des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNA	79
4.5.3	Diagramme d'ISHIKAWA des causes probables de la faible performance de certaines sous-composantes aux CNT.....	80
4.5.4	Analyse de l'impact de la faible performance des sous-composantes aux CNA/CNT de la zone sanitaire Djougou-Copargo-Ouaké en 2024.....	81
✍	Centres nutritionnels ambulatoires	81
4.5.5	Stratégie de renforcement	81
5.1	Atteinte des objectifs.....	84
5.2	Limites de l'étude et la validité des résultats	85

5.3	Comparaison des résultats avec ceux d'autres auteurs	85
5.3.1	Structure de prise en charge	85
5.3.2	Processus de prise en charge	87
5.3.3	Résultats de prise en charge	87
6.1	Plan de renforcement de la performance de la prise en charge MAS	92
6.1.1	Contexte et justification	92
6.1.2	But	92
6.2	Objectifs.....	92
6.2.1	Objectif général	92
6.2.2	Objectifs spécifiques	93
6.3	Stratégies.....	93
6.4	Cadre de mise en œuvre	93
6.5	Coordination, surveillance et évaluation	94
6.6	Chronogramme des activités du plan tactique de 3 ans.....	95